Sistema de Información del

Sistema Nacional para la Seguridad Transfusional

SISNST

ACTIVIDAD CENTROS Y SERVICIOS TRANSFUSIÓN

2025

División de Sangre, Componentes Sanguíneos, Células y Tejidos Reproductores

D.G. de Salud Pública y Equidad en Salud

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD

Sistema Nacional de Salud

Actividad de Centros y Servicios de Transfusión

Informe 2025

Índice

Introducción 1
Abreviaturas y siglas 3
Donaciones 4
Obtención de componentes sanguíneos 6
Transfusión 7
Balance Obtención-Transfusión 8
Plasma enviado a Industria Fraccionadora 9
Derivados Plasmáticos 10
Donantes 12
Promoción 16
Lugar de Colecta 17
Laboratorio 18
Autotransfusión 20
Componentes no utilizados 21
Control de Calidad 25

Anexo. Indicadores desglosados por CCAA (año 2025) 26

Introducción

Las donaciones de sangre y componentes sanguíneos resultan indispensables para garantizar una adecuada asistencia sanitaria, contribuyendo al apoyo de procedimientos médicos y quirúrgicos complejos y mejorando la salud y calidad de vida de gran número de pacientes.

En el contexto actual, marcado por una creciente incertidumbre derivada de crisis sanitarias, conflictos bélicos y el aumento de catástrofes naturales asociadas al cambio climático, se hace aún más necesario reforzar los sistemas de donación para asegurar la disponibilidad de sangre y sus componentes.

En este sentido, cobra especial relevancia las donaciones voluntarias, altruistas y no remuneradas, que constituyen la base de un sistema seguro, ético y sostenible. Este carácter voluntario es esencial para garantizar valores fundamentales como el compromiso social, la autosuficiencia y la resiliencia demostrada de los sistemas sanitarios públicos.

Uno de los objetivos estratégicos nacionales es alcanzar una suficiencia adecuada en plasma destinado a la fabricación de medicamentos derivados del mismo, lo que hace imprescindible incrementar la base de donantes mediante programas de plasmaféresis. El fomento de la concienciación ciudadana sobre la importancia de la donación de plasma, manteniendo el enfoque de donación voluntaria y no remunerada, resulta indispensable para el aumento de la disponibilidad de este recurso esencial. La obtención de mayores volúmenes de plasma permitirá reforzar la producción de medicamentos derivados del mismo, necesario para el tratamiento de numerosas enfermedades de carácter crónico.

En el marco de la actual situación internacional, caracterizada por la incertidumbre global y las tensiones en el suministro internacional, avanzar hacia la suficiencia se convierte en un elemento clave para reducir la dependencia de terceros países, garantizar el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y asegurar el acceso equitativo y sostenido a estos tratamientos esenciales.

La transfusión sanguínea es una actividad habitual en la práctica diaria de la actividad asistencial. Su vital relevancia, la consideración de la sangre y sus componentes como sustancias críticas y las peculiaridades que diferencian los componentes sanguíneos de otras medidas terapéuticas, así como de otras sustancias de origen humano, obligan a disponer de una información permanente y rigurosa que permita conocer y evaluar su uso y asimismo facilite una toma de decisiones.

El Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión, crea el Sistema Nacional para la Seguridad Transfusional (SNST), y establece que, a efectos de coordinación y planificación, las Comunidades Autónomas (CCAA) comunicarán al Ministerio de Sanidad (MS), con periodicidad anual la actividad desarrollada por los Centros y Servicios de Transfusión Sanguínea (CT/ST).

El “Reglamento (UE) 2024/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser humano y por el que se derogan las Directivas 2002/98/CE y 2004/23/CE”, establece un marco regulatorio común para todas las sustancias de origen humano (SoHO), facilitando la libre circulación de estas sustancias dentro de la UE y garantizando un nivel equivalente de calidad, seguridad de estas sustancias y la protección tanto para las personas donantes como para las receptoras en todos los Estados miembros.

En el mismo, se refuerza la importancia de la notificación anual de los datos de actividad. Por esta razón, la recopilación rigurosa de la actividad en sangre y sus componentes, independientemente de su destino final en el presente informe continua y seguirá siendo fundamental para la planificación, evaluación y mejora continua del sistema a nivel nacional, otorgándole una mayor relevancia al integrarse en un sistema europeo en el que se refuerza la transparencia, la comparación de la información, la garantía de calidad y la seguridad.

En este contexto, resulta necesario subrayar que el ámbito de las sustancias de origen humano, y en particular de la sangre y sus componentes, no se limita a su utilización con fines transfusionales, sino que comprende igualmente otras aplicaciones incluyendo la fabricación de medicamentos derivados del plasma y la obtención de componentes destinados a usos terapéuticos no transfusionales. Esta consideración integral resulta esencial para reflejar adecuadamente la realidad asistencial y productiva del sistema, así como para evitar interpretaciones restrictivas que fragmenten de forma innecesaria un ámbito funcionalmente unitario.

Conocer la actividad de los centros y servicios permite el análisis y evaluación periódica de esta práctica, y la determinación de estándares y procedimientos adaptados a la actividad clínica que se realice en cada centro hospitalario, funciones estas encomendadas a los Comités Hospitalarios de Transfusión (CHT).

La información recogida servirá, así mismo, para dar respuesta a la demanda de las instituciones europeas e internacionales relacionadas con la materia.

Material y métodos

El Sistema de Información del Sistema Nacional para la Seguridad Transfusional (SI-SNST) se alimenta del registro de actividad de los centros y servicios de transfusión, y del registro del sistema nacional de hemovigilancia.

Los datos han sido aportados por los 20 Centros de Transfusión Sanguínea pertenecientes a las 17 CCAA*, y por 505 Servicios Hospitalarios de Transfusión (252 públicos y 253 privados), a través de la aplicación web desarrollada por el Ministerio de Sanidad (MS). La información ha sido previamente validada por cada CA. A efectos de homologación de conceptos las definiciones quedan recogidas en los manuales de terminología incluidos en la aplicación.

El informe incluye datos de los últimos 5 años al objeto de reflejar tendencias, y resalta expresamente el último año considerado (2025).

A efectos comparativos, se ha utilizado como fuente complementaria de datos: 1. European Committee (Partial Agreement) on Blood Transfusion (CD-P-TS). The collection, supply and use of blood and blood components in Europe - 2020 - 2023 Report. Strasbourg: European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM); 2025.

Previo a su publicación, ha sido revisado y analizado por el Comité Científico para la Seguridad Transfusional (CCST).

* Los CTS de la CA de Andalucía se han considerado como un solo centro a efectos de este informe.

Abreviaturas y Siglas

ACSA: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
CA: Comunidad Autónoma
CAT: Comité de Acreditación en Transfusión
CCAA: Comunidades Autónomas
CCST: Comité Científico para la Seguridad Transfusional
CH: Concentrados de Hematíes
CHT: Comité Hospitalario de Transfusión
CPP: Plasma pobre en crioprecipitados
Criop: Crioprecipitados
CS: Componentes Sanguíneos
CT: Centros de Transfusión Sanguínea
DT: Dosis Terapéuticas
DVNR: Donación Voluntaria No Remunerada
Factor IXp: Factor IX plasmático
Factor VIIIp: Factor VIII plasmático
g: Gramos
HTLV: Virus Linfotrópico de células T Humano
ISBT-128: Norma de codificación de componentes sanguíneos de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
ISO: Organización Internacional de Normalización
L: Litros
MS: Ministerio de Sanidad
Multicomp: Multicomponentes
NAT: Técnicas de Amplificación de Ácidos Nucleicos
PC: Plasma Congelado
PF: Punto Fijo
PFC: Plasma Fresco Congelado
PQ: Plaquetas
RD: Real Decreto
SC: Sangre Completa
SI-SNST: Sistema de Información del Sistema Nacional para la Seguridad Transfusional
SNST: Sistema Nacional para la Seguridad Transfusional
ST: Servicios de Transfusión
T. Cruzi: *Trypanosoma Cruzi*
U: Unidades
UE: Unión Europea
UI: Unidades Internacionales
VHB: Virus de la Hepatitis B
VHC: Virus de la Hepatitis C
VHE: Virus de la Hepatitis E
VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana
VNO: Virus del Nilo Occidental

Agradecimientos

La División de Sangre, Componentes Sanguíneos, Células y Tejidos Reproductores agradece la colaboración de los responsables de los Centros de Transfusión, de los profesionales de los Servicios de Transfusión participantes, así como de los Servicios de Farmacia Hospitalaria correspondientes.

Donaciones

El 91,65% de las donaciones realizadas se corresponden con donaciones de sangre completa. Tal como refleja la Tabla 1, el índice de donación se sitúa en 33,96 por 1.000 habitantes.

Se aprecia una tendencia descendente y mantenida en el número de donaciones de sangre completa en contraste con el aumento continuado de las donaciones mediante procedimientos de aféresis, que registran un incremento del 11,50% respecto al año 2024.

Media europea: *37,37 por 1.000 habitantes donaciones SC.*

España: *31,12 por 1.000 habitantes donaciones SC.*

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
Donaciones SC	1.622.610	1.616.913	1.564.886	1.553.830	**1.523.196**	**-1,97**
Donaciones Aféresis	97.792	99.866	112.983	124.515	**138.839**	**11,50**
Total Donaciones	1.720.402	1.716.779	1.677.869	1.678.345	**1.662.035**	**-0,97**
Índice de Donación (SC + aféresis)	36,48	36,18	35,36	34,66	**33,96**	
Índice de Donación SC	34,41	34,08	32,98	32,09	**31,12**	
Índice de Donación Aféresis	2,07	2,10	2,38	2,57	**2,84**	

Tabla 1. Donaciones de sangre total y aféresis e índices de donación. (2021-2025)

Aféresis

Los procesos de plasmaféresis se han incrementado un **17,13%**, lo que ha permitido obtener, un total de **67.551 litros de plasma** mediante este procedimiento. Esta cifra supone un aumento del **19,53%** respecto al volumen de plasma obtenido mediante plasmaféresis en 2024. Aunque el volumen alcanzado sigue siendo inferior a lo deseable para lograr un nivel adecuado de suficiencia, se aprecia una **tendencia ascendente sostenida desde el año 2021**.

Por otro lado, cabe destacar que **los procesos de plasmaféresis constituyeron el 78,01%** de total de procesos de aféresis realizados.

Asimismo, se observa un ligero incremento en los procesos de tromboféresis, junto con una disminución en los de aféresis de multicomponentes, más acusada en el caso de la eritroféresis, y la ausencia de procesos de leucocitoféresis.

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
Plasmaféresis	65.030	66.385	81.186	92.464	**108.304**	**17,13**
Multicomponente*	31.495	30.210*	30.351*	30.672*	**29.220***	**-4,73**
Eritroféresis	226	303	198	213	**141**	**-33,80**
Tromboféresis	1.041	2.956	1.248	1.163	**1.174**	**0,95**
Leucocitoféresis	0	12	0	3	**0**	**-100,00**

Tabla 2. Número de procedimientos de aféresis. (2021-2025)

(*) En el apartado correspondiente a los procesos de aféresis de multicomponente se incluyen también los procesos de aféresis de plaquetas más plasma.

Donaciones

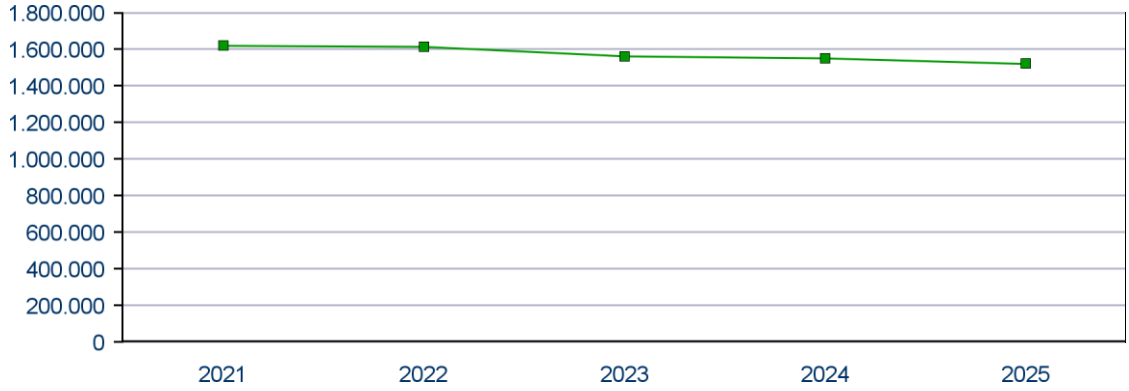


Gráfico 1. Número de Donaciones de Sangre Completa. (2021-2025)

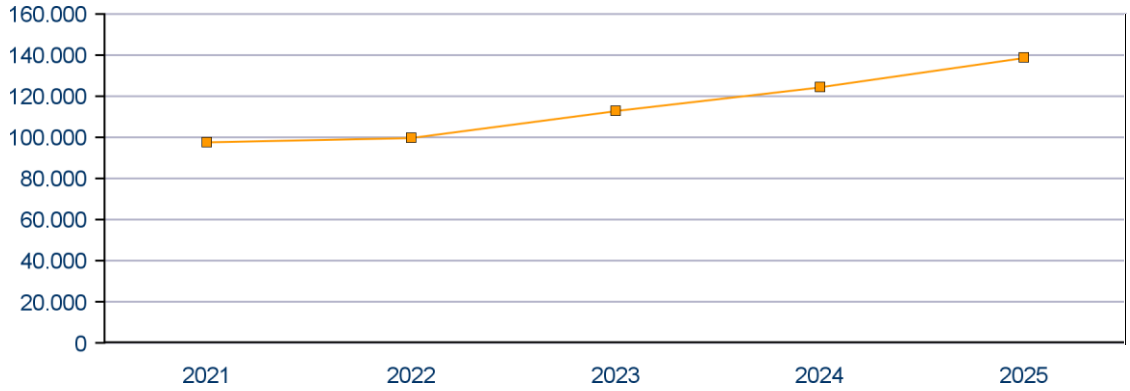


Gráfico 2. Número de Donaciones de Aféresis. (2021-2025)

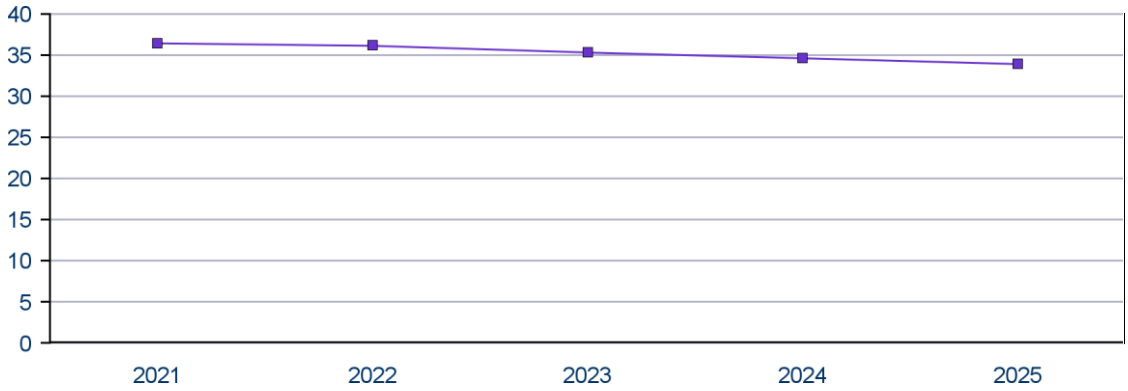


Gráfico 3. Índice de Donación. (2021-2025)

Obtención de componentes sanguíneos

Los principales componentes obtenidos se recogen en la tabla 3. Se observa una ligera disminución en la obtención de unidades de hematíes y de dosis terapéuticas de plaquetas, acorde con la menor demanda hospitalaria actual, así como, un ligero incremento en la obtención de plasma.

Por otro lado, tal como se refleja en la tabla 4, desde 2021 se observa una tendencia ascendente y continuada en la obtención del **plasma procedente de plasmaféresis** que registra en 2025 un incremento del **19,53%** respecto al año 2024, en contraste con la tendencia descendente en la obtención del plasma procedente de donaciones de sangre total.

Las tasas de obtención de cada componente por 1.000 habitantes se reflejan en la tabla 5.

Media europea: *36 CH (U) por 1.000 habitantes, 7 PQ (DT) por 1.000 habitantes y 12 PFC (U) por 1.000 habitantes.*

España: *30 CH (U) por 1.000 habitantes, 6 PQ (DT) por 1.000 habitantes y 39 PFC (U) por 1.000 habitantes.*

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
CH (U)	1.582.083	1.578.506	1.529.122	1.513.851	**1.485.980**	**-1,84**
PQ (DT)	269.254	274.723	272.443	273.892	**273.268**	**-0,23**
PFC (L)	455.925	478.247	460.647	471.995	**478.229**	**1,32**

Tabla 3. Evolución de la obtención de componentes sanguíneos. (2021-2025)

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
Plasma procedente de donaciones de ST (L)	410.827,09	427.321,97	398.750,77	404.061,07	**398.427,49**	**-1,39**
Plasma procedente de plasmaféresis (L)	35.090,44	40.388,97	50.462,42	56.514,89	**67.551,06**	**19,53**
Plasma procedente de aféresis de multicomponentes (L)	9.842,80	10.429,18	11.295,47	11.229,81	**12.107,58**	**7,82**

Tabla 4. Evolución de la obtención de plasma. (2021-2025)

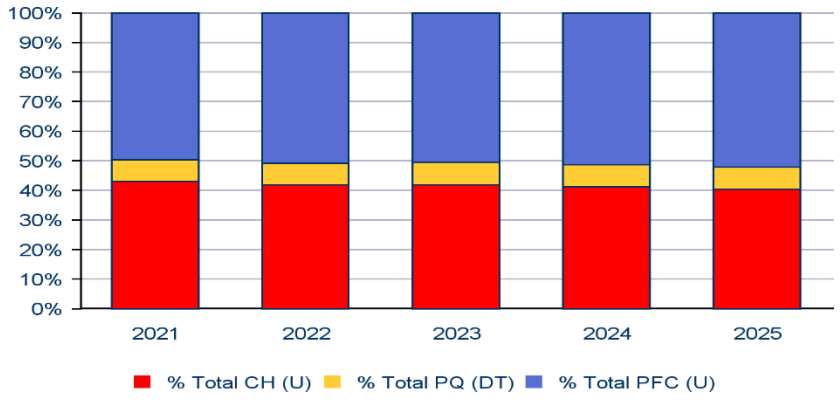


Gráfico 4. Distribución porcentual de obtención de los principales componentes sanguíneos. (2021–2025)

	x 1.000 habitantes
CH (U)	30
PQ (DT)	6
PFC (L)	10

Tabla 5. Tasas de obtención de componentes sanguíneos por 1.000 habitantes. 2025

Transfusión

La cantidad y tipos de componentes transfundidos se incluyen en la tabla 6. En el año 2025, se **transfundieron 1.785.184 componentes sanguíneos y 470.784 pacientes recibieron una transfusión** (82,71% recibieron hematíes, 11,93% plaquetas, 5,34% plasma y 0,01% crioprecipitados).

Se observa una disminución general en la transfusión de componentes sanguíneos, excepto en la transfusión de dosis terapéuticas de plaquetas, que registran un ligero incremento.

La realización de procedimientos de exanguinotransfusión presenta una marcada disminución, con cifras más similares a las notificadas antes del año 2024. Asimismo, se evidencia un notable descenso en la transfusión de crioprecipitados y plasma pobre en crioprecipitados. Por su parte, la transfusión de hematíes y de plasma disminuyen ligeramente, siendo dicho descenso más acusado en el caso del plasma.

Media europea: *46,82 CS transfundidos por 1.000 habitantes: 77,5% hematíes, 13,3% plaquetas, 9,2% plasma.*

España: *36,47 CS transfundidos por 1.000 habitantes: 80,0% hematíes, 13,9% plaquetas, 6,0% plasma.*

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
SC (U)	5	19	10	33	**19**	**-42,42**
CH (U)	1.514.963	1.493.369	1.464.986	1.436.700	**1.428.924**	**-0,54**
PQ (DT)	245.140	240.359	245.332	245.550	**248.434**	**1,17**
PFC (U)	138.719	129.436	118.339	113.798	**107.257**	**-5,75**
Criop (U)	534	295	393	404	**339**	**-16,09**
CPP (U)	209	116	412	248	**211**	**-14,92**
Índice CH (U x 1.000 habitantes)	32,12	31,47	30,87	29,67	**29,20**	
Índice PQ (DT x 1.000 habitantes)	5,20	5,07	5,17	5,07	**5,08**	
Índice PFC (U x 1.000 habitantes)	2,94	2,73	2,49	2,35	**2,19**	
Índice Criop (U x 1.000 habitantes)	0,01	0,01	0,01	0,01	**0,01**	
Índice CPP (U x 1.000 habitantes)	0,00	0,00	0,01	0,01	**0,00**	

Tabla 6. Cantidad y tipos de componentes sanguíneos transfundidos. (2021-2025)

	Número Pacientes Transfundidos
SC	16
CH	389.406
PQ	56.164
PFC	25.151
Criop	39
CPP	8

Tabla 7. Número total de pacientes transfundidos por tipo de componente sanguíneo. 2025

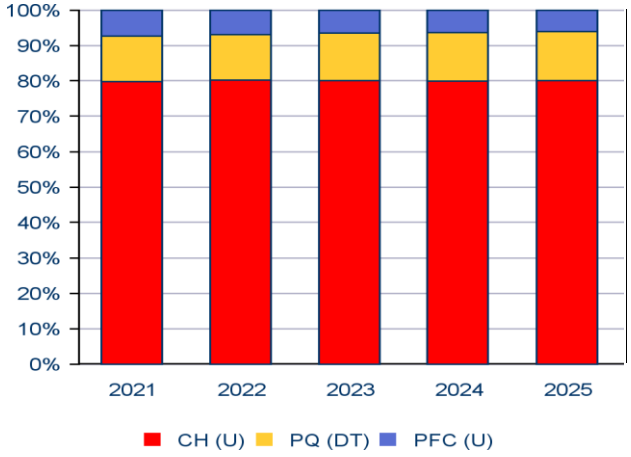


Gráfico 5. Distribución porcentual de transfusión de los principales componentes sanguíneos. (2021-2025)

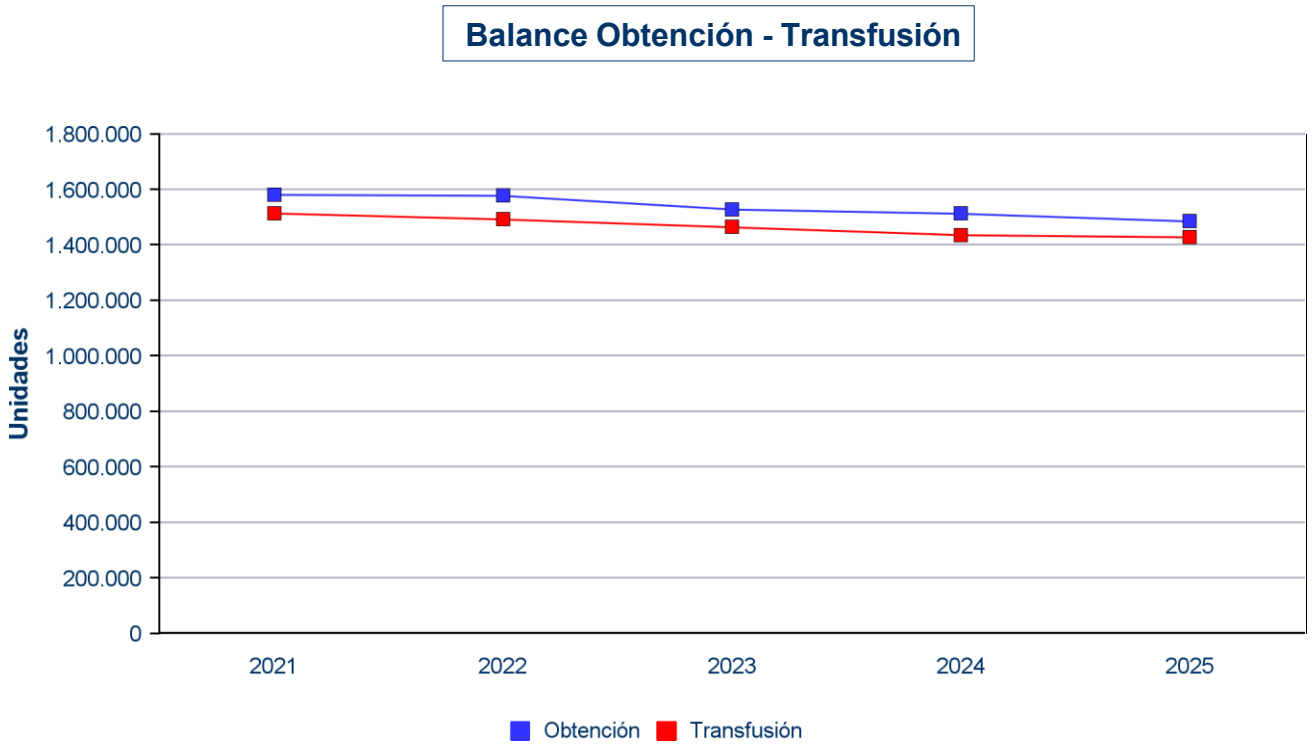


Gráfico 6. Balance obtención-transfusión de unidades de hematíes. (2021-2025)

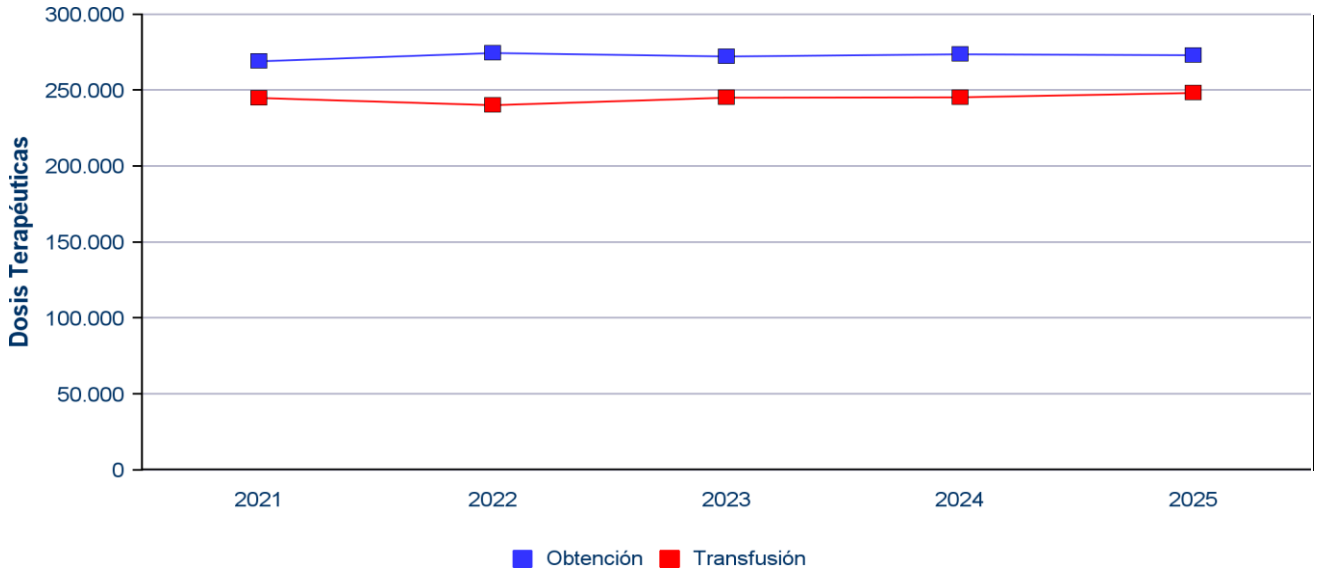


Gráfico 7. Balance obtención-transfusión de dosis terapéuticas de plaquetas. (2021-2025)

Plasma enviado a Industria Fraccionadora

Conforme al objetivo de alcanzar la autosuficiencia en derivados plasmáticos basada en la DVNR, los CT envían a la industria fraccionadora tanto el plasma procedente de procesos de aféresis como el recuperado de las donaciones de sangre total. El volumen enviado en 2025 ascendió a un total de **422.784,67 litros**, lo que supone un total de **8,64 litros por 1.000 habitantes**, de los cuales el **17,23% (72.842,66 litros) procedían de donaciones de aféresis**. A efectos comparativos, **en 2025** se ha registrado un incremento del **16,76%** en el volumen de **plasma procedente de aféresis** enviado a la industria fraccionadora con **respecto al año 2024.**

Aunque en 2025 se ha producido una disminución del volumen total de plasma enviado a la industria, esta reducción se debe principalmente al descenso del plasma procedente de donaciones de sangre total. Por el contrario, el plasma obtenido mediante aféresis muestra una tendencia ascendente, alcanzando en 2025 el valor más elevado de toda la serie.

Se debe tener en cuenta que en el año 2025 se notificó el envío a la industria fraccionadora de **484,88 litros** de plasma cuyo origen no se especifica, es decir, no se indica si proceden de donaciones de sangre total o de aféresis.

Media europea: *17,12 litros de plasma enviados a la industria fraccionadora por 1.000 habitantes. Variación relativa por año: 1,3% (0,0% - 2,7%).*

España: *8,64 litros de plasma enviados a la industria fraccionadora por 1.000 habitantes.*

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
Plasma total enviado a la industria (L)	407.856,88	412.980,48	417.810,71	427.492,10	**422.784,67**	**-1,10**
Plasma enviado a la industria procedente de donaciones de Sangre Total (L)	-	361.248,40	362.138,62	365.060,98	**349.457,13**	**-4,27**
Plasma enviado a la industria procedente de donaciones de Aféresis (L)	-	43.216,71	55.421,74	62.384,39	**72.842,66**	**16,76**

Tabla 8. Total de litros de plasma fresco congelado enviado a la industria fraccionadora y procedencia. (2021-2025)

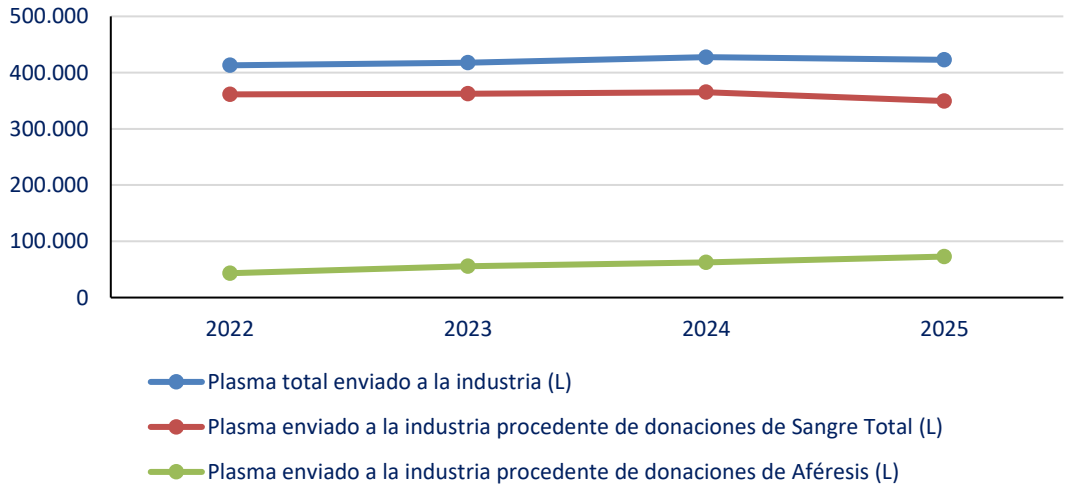


Gráfico 8. Evolución del volumen de plasma (expresado en litros) enviado a la industria fraccionadora según procedencia. (2022-2025)

Derivados Plasmáticos

Producción

La tabla 9 recoge las cantidades de los derivados plasmáticos obtenidos a partir del fraccionamiento del plasma obtenido en el ámbito nacional.

Durante el año 2025, se observa una disminución en la producción de la mayoría de los derivados plasmáticos, destacando el descenso en la producción de factor IX plasmático. Como excepción, aumenta la producción de factor VIII plasmático, que registra un notable incremento, así como, la de antitrombina-III con un incremento significativo.

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
Albúmina (g)	10.708.689	12.090.526	10.555.856	12.010.550	**11.698.950**	**-2,59**
Inmunoglobulinas (g)	1.705.676	1.806.245	1.717.952	1.969.240	**1.949.030**	**-1,03**
Factor VIIIp (Ul)	32.641.738	34.523.500	28.894.000	25.313.500	**27.539.000**	**8,79**
Factor IXp (UI)	3.823.980	5.382.000	5.845.000	7.069.000	**4.152.000**	**-41,26**
Antitrombina III (UI)	2.311.000	768.600	1.226.500	1.484.500	**2.275.000**	**53,25**
Alfa-1-Antitripsina (g)	69.290	75.532	70.525	89.063	**84.680**	**-4,92**
Fibrinógeno (g)	-	0	0	0	**0**	-
Complejo Protrombínico (UI)	-	0	0	0	**0**	-
Inhibidor C1 Esterasa (UI)	-	0	0	0	**0**	-

Tabla 9. Producción de derivados plasmáticos a partir del fraccionamiento del volumen total del plasma obtenido en el ámbito nacional. (2021-2025)

Derivados Plasmáticos

Consumo

Las cifras que se presentan corresponden al consumo notificado por parte de la red hospitalaria (centros públicos y privados), e incluye tanto el consumo de derivados elaborados a partir del plasma obtenido en los CT del país, como el consumo procedente de las compras de los hospitales a las compañías farmacéuticas.

El análisis de la evolución del consumo de derivados plasmáticos en el periodo 2021-2025 muestra, en términos generales, una tendencia creciente y mantenida del consumo de inmunoglobulinas, de factor VIII plasmático, de alfa-1-antitripsina, de complejo protrombínico y de inhibidor C1 esterasa.

Aunque algunos derivados presentan cambios puntuales en el periodo analizado, **la tendencia global evidencia un aumento mantenido del consumo de derivados plasmáticos.**

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
Albúmina (g)	17.987.973	18.657.996	18.606.003	18.645.816	**18.246.809**	**-2,14**
Inmunoglobulinas (g)	5.087.969	5.051.811	6.194.554	6.755.299	**7.513.626**	**11,23**
Factor VIIIp (UI)	62.893.806	59.115.887	62.648.904	67.248.541	**70.385.964**	**4,67**
Factor IXp (UI)	9.443.858	8.932.140	9.026.307	9.624.200	**8.737.100**	**-9,22**
Antitrombina III (UI)	2.655.299	2.780.540	2.593.013	2.619.730	**2.186.000**	**-16,56**
Alfa-1-Antitripsina (g)	130.580	139.411	151.028	165.900	**169.447**	**2,14**
Fibrinógeno (g)	-	99.126	79.550	76.940	**93.902**	**22,05**
Complejo Protrombínico (UI)	-	28.693.802	34.465.423	35.497.285	**38.716.820**	**9,07**
Inhibidor C1 Esterasa (UI)	-	2.999.736	6.935.000	13.306.360	**15.934.500**	**19,75**
Albúmina (g por 1.000 habitantes)	381,42	393,21	392,12	385,09	**372,81**	
Inmunoglobulinas (g por 1.000 habitantes)	107,89	106,47	130,55	139,52	**153,51**	
Factor VIIIp (UI por 1.000 habitantes)	1.333,61	1.245,85	1.320,31	1.388,89	**1.438,09**	
Factor IXp (UI por 1.000 habitantes)	200,25	188,24	190,23	198,77	**178,51**	
Antitrombina III (UI por 1.000 habitantes)	56,30	58,60	54,65	54,11	**44,66**	
Alfa-1-Antitripsina (g por 1.000 habitantes)	2,77	2,94	3,18	3,43	**3,46**	
Fibrinógeno (g por 1.000 habitantes)	-	2,09	1,68	1,59	**1,92**	
Complejo Protrombínico (UI por 1.000 habitantes)	-	604,72	726,35	733,13	**791,04**	
Inhibidor C1 Esterasa (UI por 1.000 habitantes)	-	63,22	146,15	274,82	**325,57**	

Tabla 10. Consumo de derivados plasmáticos. (2021-2025)

Donantes

Donantes registrados

El número y evolución de los donantes registrados según categorías queda recogido en la tabla 11. En 2025, el número de donantes activos en la población general ha sido de 21,87 por 1.000 habitantes y la media de donaciones realizadas por donante de 1,55. Esta cifra indica la existencia de una base de donantes suficiente para garantizar el suministro de sangre. De estos, el 16,6% han sido donantes de primera vez y se observa un incremento de las donaciones realizadas por donantes conocidos del 1,54% respecto al año 2024. Sin embargo, es fundamental seguir invirtiendo en esfuerzos para captar y fidelizar a los donantes, asegurando así la sostenibilidad del sistema.

Media europea: *23,93 donantes que han donado al menos una vez durante el año por 1.000 habitantes.*

España: *21,87 donantes que han donado al menos una vez durante el año por 1.000 habitantes.*

Media europea: *4,42 donantes nuevos por 1.000 habitantes.*

España: *3,63 donantes nuevos por 1.000 habitantes.*

	2021		2022		2023		2024		2025		% Variación 2024-2025
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	
Donantes Nuevos	168.972	14,9	179.481	15,7	185.448	16,5	186.875	16,8	**177.800**	**16,6**	**-4,86**
Donantes Habituales	799.578	70,6	796.262	69,5	768.131	68,2	772.003	69,4	**736.028**	**68,8**	**-4,66**
Donantes Conocidos	164.581	14,5	170.143	14,8	172.766	15,3	153.968	13,8	**156.341**	**14,6**	**1,54**
Total Donantes	1.133.131		1.145.886		1.126.345		1.112.846		**1.070.169**		**-3,83**
Donaciones por donante	1,52		1,50		1,49		1,51		**1,55**		
Donantes por 1.000 habitantes	24,03		24,15		23,74		22,98		**21,87**		

Tabla 11. Número de donantes registrados y donaciones realizadas por donante. (2021-2025)

Donantes excluidos

La tasa total de exclusión (porcentaje total de donantes excluidos, ya sea de forma temporal o permanente, respecto al total de donantes registrados) ha sido del 19,48% en el año 2025.

	2021		2022		2023		2024		2025		% Variación 2024-2025
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	
Excluidos Temporales	183.566	92,8	201.616	92,7	200.967	92,9	200.736	93,2	**191.797**	**92,0**	**-4,45**
Excluidos Permanentes	14.197	7,2	15.839	7,3	15.414	7,1	14.654	6,8	**16.657**	**8,0**	**13,67**
Total Excluidos	197.763		217.455		216.381		215.390		**208.454**		**-3,22**
Índice Exclusión Temporal	16,20		17,59		17,84		18.04		**17,92**		
Índice Exclusión Permanente	1,25		1,38		1,37		1,32		**1,56**		
Índice Exclusión	17,45		18,98		19,21		19,35		**19,48**		

Tabla 12. Número de donantes excluidos. (2021-2025)

A continuación, se muestran una serie de gráficos en las que se representan las tasas del número de personas donantes en función del sexo y los rangos de edad representados.

Las tasas se han calculado a partir de los datos de la población a 1 de enero de 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadística. (INE)

Para el grupo de edad de más de 65 años, se ha considerado únicamente la población comprendida entre los 65 y los 70 años, dado que, a partir de esta edad, la probabilidad de que existan personas donantes es muy reducida.

Asimismo, en los resultados presentados no ha sido posible incorporar los datos correspondientes a una CA, debido a que los intervalos de edad disponibles en la información facilitada no eran comparables con los rangos de edad definidos para este análisis.

En conjunto, los resultados ponen de manifiesto que la captación de nuevos donantes se concentra principalmente en las edades más jóvenes, mientras que la permanencia y actividad en la donación tienden a ser más frecuentes en los grupos de mayor edad, especialmente entre los hombres.

En el gráfico 9, se puede observar que la distribución de las tasas de nuevos donantes registrados muestra un claro predominio de los grupos más jóvenes. Tanto en mujeres como en hombres, la mayor tasa se observa en el grupo de 18 a 25 años, con valores de 19,44 y 15,03 por 1.000 habitantes, respectivamente. A partir de esta edad se aprecia un descenso progresivo de las tasas de incorporación de nuevos donantes.

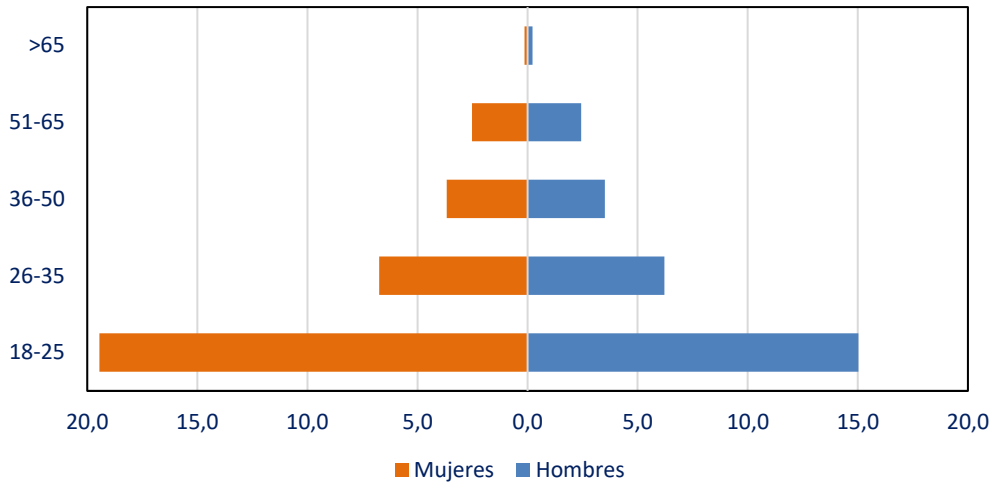


Gráfico 9. Tasa de donantes nuevos por sexo y rango de edad. 2025

En el gráfico 10, en relación con los donantes habituales registrados, entendiendo como “donante habitual” a toda aquella persona que ha donado durante el 2025 y ha efectuado alguna donación en los dos años anteriores (2024 y 2023), se observa un patrón diferente. Aunque las mujeres presentan tasas superiores en los grupos de 18 a 25 años (20,72 por 1.000 habitantes), los hombres muestran un incremento progresivo con la edad, alcanzando el valor máximo en el grupo de 51 a 65 años (32,12 por 1.000 habitantes). Este resultado sugiere una mayor consolidación de la práctica de la donación entre los hombres de edades intermedias y avanzadas.

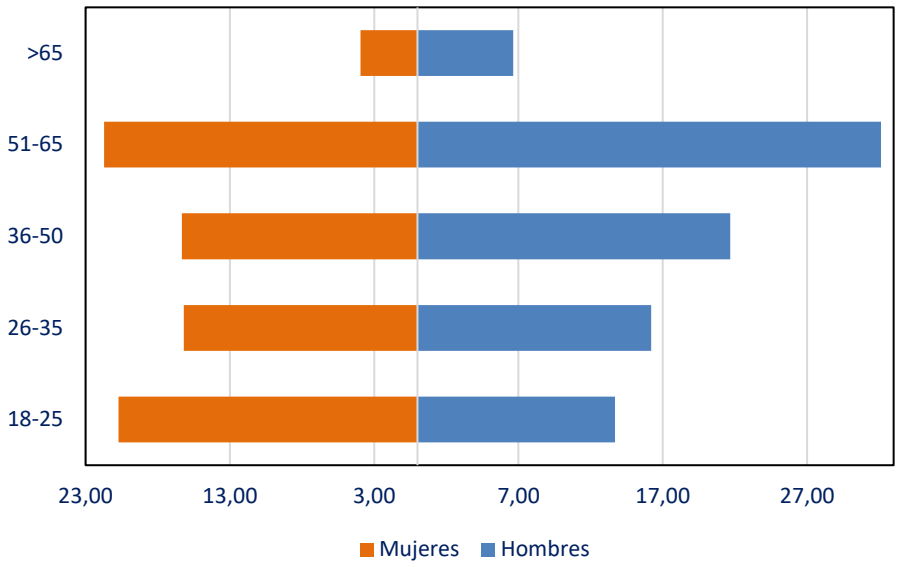


Gráfico 10. Tasa de donantes habituales por sexo y rango de edad. 2025

Por último, como se puede observar en el gráfico 11, las tasas de donantes activos de plasmaféresis, por el momento, continúan siendo bajas en comparación con las categorías anteriores, aunque muestran una tendencia creciente con la edad hasta el grupo de 51 a 65 años. Asimismo, se puede observar que, en todos los grupos etarios, los hombres presentan tasas ligeramente superiores a las de las mujeres, alcanzando el valor máximo de 2,76 por 1.000 habitantes en el grupo de 51 a 65 años.

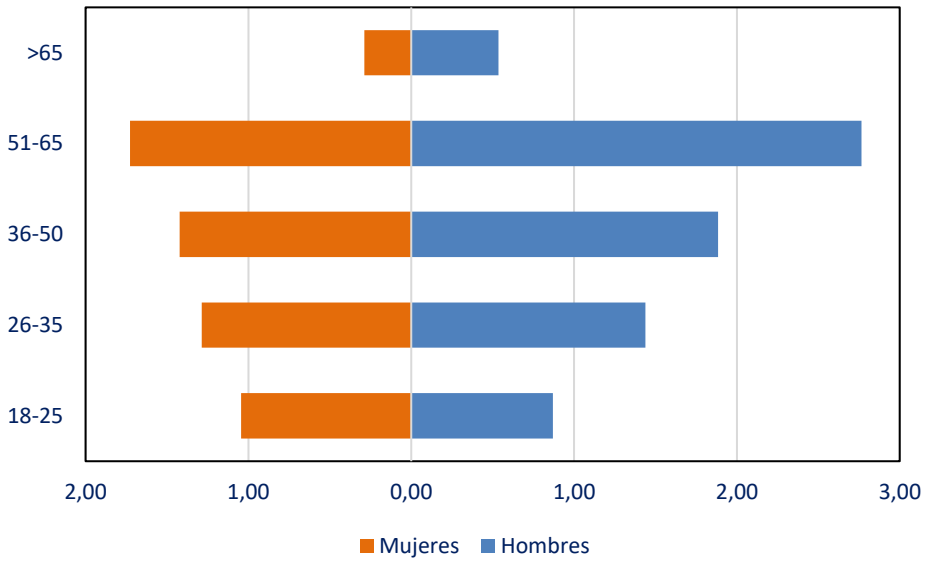


Gráfico 11. Tasa de donantes activos de plasmaféresis por sexo y rango de edad. 2025

En el gráfico 12 se puede observar la evolución anual del número de donantes nuevos de plasmaféresis entre 2021 y 2025. No obstante, esta evolución debe interpretarse teniendo en cuenta ciertas limitaciones en la disponibilidad de datos, ya que no se dispone de información en 2021 para tres CCAA y en 2022 para siete CCAA. Circunstancia que explica la caída observada en 2022.

A pesar de estas discrepancias, se aprecia una tendencia general en un incremento progresivo en el número de donantes nuevos de plasmaféresis reclutados a lo largo del periodo analizado.

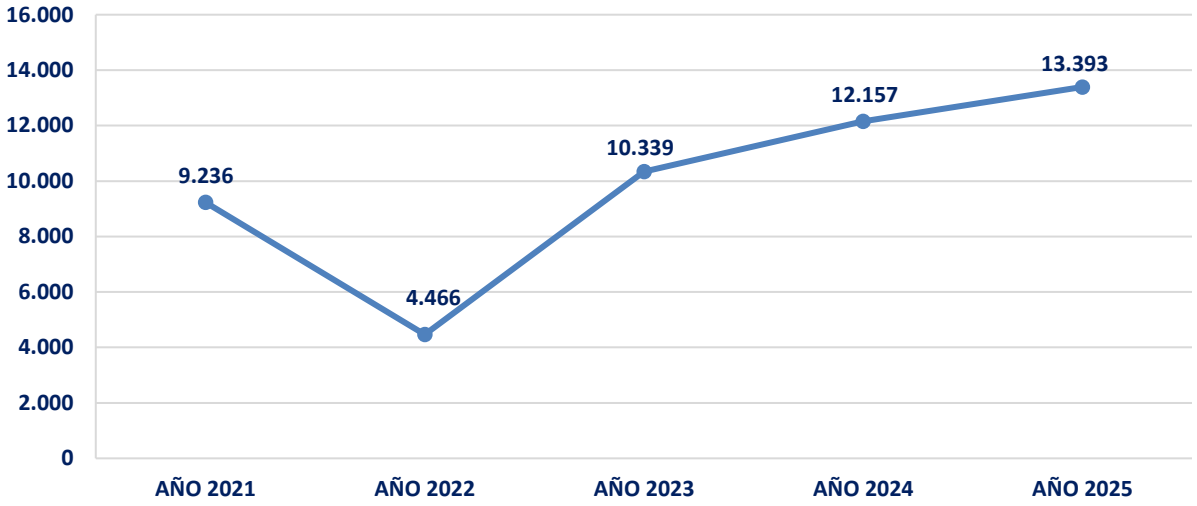


Gráfico 12. Número de donantes nuevos de plasmaféresis. (2021-2025)

Promoción

Diseñar programas de promoción de la donación es una de las actividades fundamentales de los CT dado que son los responsables de garantizar el suministro adecuado de los productos sanguíneos. Estos programas resultan esenciales para asegurar un número suficiente de donaciones para cubrir los requerimientos hospitalarios y para contribuir con la eficiencia y eficacia del sistema de salud.

Actividades para el Fomento de la Donación Voluntaria No Remunerada (DVNR)

En el año 2025 el número y tipo de actividades de promoción llevadas a cabo por los 20 CT se reflejan en las siguientes tablas. Se observa un incremento llamativo de las campañas por sectores de edad realizadas, así como, un incremento de las charlas informativas impartidas en todos los ámbitos, aunque destacan aquellas llevadas a cabo en el ámbito universitario y en el empresarial.

También, se observa un notable incremento de los cursos formativos dirigidos tanto a profesionales como a voluntarios.

Campañas					
Generales			Sectores Edad		
2024	2025	% Variación 2024-2025	2024	2025	% Variación 2024-2025
219	190	-13,24	239	694	190,38

Tabla 13. Actividades promoción de la donación. Campañas. (2024-2025)

Charlas Informativas											
Escuela			Universidad			Empresa			Otras		
2024	2025	% Variación 2024-2025	2024	2025	% Variación 2024-2025	2024	2025	% Variación 2024-2025	2024	2025	% Variación 2024-2025
1.421	1.545	8,73	349	596	70,77	129	224	73,64	133	161	21,05

Tabla 14. Actividades promoción de la donación. Charlas informativas. (2024-2025)

Cursos Formativos					
Profesionales			Voluntarios		
2024	2025	% Variación 2024-2025	2024	2025	% Variación 2024-2025
64	81	26,56	27	33	22,22

Tabla 15. Actividades promoción de la donación. Cursos formativos. (2024-2025)

Material Difundido			Actividades en Medios de Comunicación			Eventos		
2024	2025	% Variación 2024-2025	2024	2025	% Variación 2024-2025	2024	2025	% Variación 2024-2025
300	296	-1,33	2.140	2.118	-1,03	108	90	-16,67

Tabla 16. Otras actividades para la promoción de la donación. (2024-2025)

Lugar de Colecta

Donaciones de sangre

En 2025 se ha registrado un ligero incremento de las donaciones realizadas en los ST y en los Puntos Fijos respecto al año anterior.

	2021		2022		2023		2024		2025		% Variación 2024-2025
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	
Centro de Transfusión	168.702	10,4	210.919	13,0	154.494	9,9	142.023	9,1	**131.988**	**8,7**	**-7,07**
Servicio de Transfusión / PF	312.784	19,3	313.403	19,4	281.173	18,0	280.350	18,0	**285.165**	**18,7**	**1,72**
Unidad Móvil	1.141.124	70,3	1.092.591	67,6	1.129.219	72,2	1.131.457	72,8	**1.106.043**	**72,6**	**-2,25**

Tabla 17. Número de donaciones de sangre total realizadas en función del lugar de colecta. (2021-2025)

Plasmaféresis

Se aprecia un incremento en la realización de procesos de plasmaféresis en los ST y en los Puntos Fijos, seguidas muy de cerca por aquellos realizados en las Unidades Móviles.

	2021		2022		2023		2024		2025		% Variación 2024-2025
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	
Centro de Transfusión	21.797	33,5	25.585	38,5	28.383	35,0	29.722	32,1	**28.135**	**26,0**	**-5,34**
Servicio de Transfusión / PF	24.853	38,2	19.878	29,9	28.134	34,6	32.200	34,8	**41.602**	**38,4**	**29,20**
Unidad Móvil	18.380	28,3	20.922	31,5	24.669	30,4	30.542	33,0	**38.567**	**35,6**	**26,28**

Tabla 18. Número de plasmaféresis realizadas en función del lugar de colecta. (2021-2025)

Laboratorio

Marcadores Obligatorios

Tal como se observa en el gráfico 13, los resultados de detección de los principales marcadores infecciosos muestran un descenso de la prevalencia del VIH, del VHB y del VHC.

Asimismo, se observa una disminución del 12,21% en la prevalencia de la sífilis (LUES) por cada 100.000 donaciones, situándose en 44,01 en el año 2025 frente al 50,13 en el 2024.

Respecto al marcador VHB se han notificado 60 casos de hepatitis B ocultas (HBO/OBI) entre las donaciones analizadas, lo que equivale a 3,6 casos por cada 100.000 donaciones.

Por otro lado, en lo que respecta al marcador VHC, el 40,91% de las unidades que fueron positivas se confirmaron mediante las pruebas con técnicas NAT.

Cabe destacar que el valor consignado en la columna "**Total Positivos Confirmados**" de la tabla 19, viene dado por el sumatorio del valor de la columna "**Positivos Serología**" de dicha tabla y del valor correspondiente a la columna "**2025**" de la tabla 20, en la que se indican las donaciones positivas detectadas durante el periodo ventana exclusivamente mediante NAT en ese año.

2025

	Unidades Testadas	Positivos Serología	Positivos NAT	Total Positivos Confirmados	Prevalencia por 100.000 donaciones
VIH	1.661.071	40	39	40	2,41
VHC	1.661.071	66	27	66	3,97
VHB	1.661.071	93	135	120	7,22
LUES	1.661.071	731	-	-	44,01

Tabla 19. Resultados positivos obtenidos en el cribado de los marcadores infecciosos obligatorios. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
VIH (+) Excl. NAT	2	2	0	1	**0**
VHC (+) Excl. NAT	1	0	1	0	**0**
VHB (+) Excl. NAT	59	27	31	23	**27**

Tabla 20. Donaciones positivas detectadas durante el periodo ventana exclusivamente mediante NAT. (2021-2025)

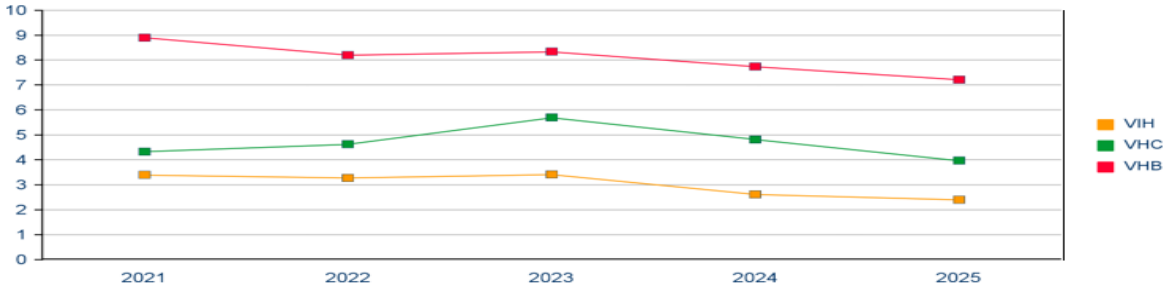


Gráfico 13. Prevalencia de VIH, VHB y VHC por cada 100.000 donaciones. Media Nacional. (2021-2025)

Laboratorio

Otros Marcadores

En el 2025, en todos los CT se ha cribado de forma selectiva el *Trypanosoma Cruzi*, agente etiológico responsable de la enfermedad de Chagas, a excepción de 1 de ellos en los que el cribado se ha realizado de forma rutinaria.

Para el marcador HTLV-I-II, 16 CT lo han cribado de forma selectiva y 4 CT de forma rutinaria.

Asimismo, se realizó un cribado selectivo para la detección de malaria en 16 CT y para el VNO en 19 CT, incorporándose durante 2025 este último cribado en 2 Centros.

Por otro lado, se realizó un cribado de forma rutinaria para el marcador VHE en 4 CT y en 1 de forma selectiva. Para el Chikungunya y el dengue en 4 CT de forma selectiva, así como, para el Zika en 2 CT de forma selectiva.

La prevalencia de dichos marcadores en 2025 se refleja en la siguiente tabla:

2025

	Unidades Testadas	Positivos	%
T. CRUZI	73.645	29	0,0394
MALARIA	53.098	313	0,5895
HTLV-I-II	620.197	23	0,0037
VNO	147.484	6	0,0041

Tabla 21. Distribución porcentual de otros marcadores infecciosos por unidades testadas. 2025

Autotransfusión

En el año 2025, este tipo de donación constituyó el 0,02% de las donaciones realizadas.

Respecto al año 2024, se observa un incremento en un 5,54% respecto al número de unidades extraídas, pero una disminución en un 13,10% respecto al número de unidades autotransfundidas, lo que supone que se autotransfundieron el 34,81% de las unidades extraídas.

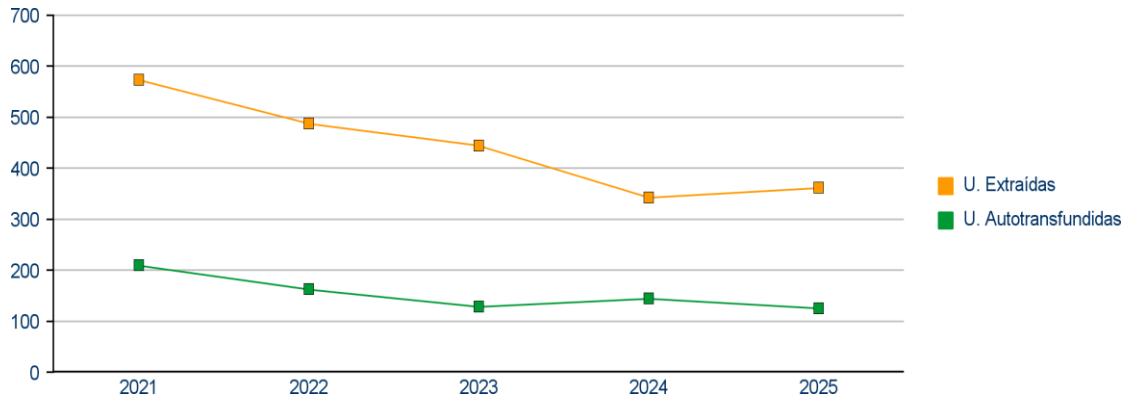


Gráfico 14. Unidades extraídas y autotransfundidas. Media Nacional 2021-2025

Componentes no utilizados

El porcentaje que representan las unidades caducadas y desechadas sobre el total de unidades obtenidas de los principales CS en los últimos años se reflejan en las dos tablas siguientes (tablas 22 y 23). En su cálculo se han considerado conjuntamente los datos suministrados por los Centros y por los Servicios de transfusión.

Las unidades caducadas son aquellas unidades de sangre o componentes que no han sido utilizadas por haber sobrepasado su periodo de validez.

Por el contrario, las unidades desechadas son aquellas que finalmente no se utilizan debido a alteraciones o incidencias distintas de la caducidad, como hemólisis, presencia de coágulos, cambios de color, rotura de la bolsa o fallos en las neveras de almacenamiento, entre otras.

	2021	2022	2023	2024	2025
CH	1,66	1,73	1,96	1,92	**1,86**
PQ	10,34	10,53	10,09	9,45	**9,49**
PFC	0,18	0,14	0,22	0,16	**0,15**

Tabla 22. Porcentaje de unidades caducadas de componentes sanguíneos respecto a las obtenidas. (2021-2025)

	2021	2022	2023	2024	2025
CH	2,38	2,67	2,26	2,34	**2,18**
PQ	2,53	2,87	2,66	2,67	**2,30**
PFC	4,38	3,93	3,98	3,39	**3,39**

Tabla 23. Porcentaje de unidades desechadas de componentes sanguíneos respecto a las obtenidas. (2021-2025)

Por otro lado, en el año 2025 la industria fraccionadora desechó 4.135 unidades de plasma, lo que supone una disminución del **29,51%** respecto a las unidades desechadas en 2024.

Unidades Caducadas en los CT y ST

	2021		2022		2023		2024		2025		% Variación 2024-2025	% Variación 2024-2025
	CT	ST	CT	ST	CT	ST	CT	ST	CT	ST	CT	ST
SC (U)	7	11	210	20	59	29	12	4	**26**	**7**	**116,67**	**75,00**
CH (U)	9.984	16.258	11.452	15.963	12.391	17.520	12.365	16.709	**12.374**	**15.333**	**0,07**	**-8,24**
PQ (DT) (ST + Aféresis)	**9.099**	**18.752**	**9.265**	**19.656**	**9.826**	**17.668**	**8.550**	**17.340**	**7.951**	**17.989**	**-7,01**	**3,74**
PQ (DT) procedentes de ST	8.775	16.624	8.908	18.144	9.391	16.299	8.139	15.996	7.670	16.397	**-5,76**	**2,51**
PQ (DT) procedentes de Aféresis	324	2.128	357	1.512	435	1.369	411	1.344	281	1.592	**-31,63**	**18,45**
PFC (U)	1.481	1.819	934	1.786	2.278	1.697	1.434	1.632	**1.168**	**1.763**	**-18,55**	**8,03**
Criop (U)	172	227	575	85	67	42	45	16	**32**	**27**	**-28,89**	**68,75**
CPP (U)	248	0	549	1	40	2	53	2	**54**	**0**	**1,89**	**-100,00**

Tabla 24. Número total de componentes sanguíneos caducados en los Centros de transfusión y en los Servicios de transfusión. (2021-2025)

Unidades Desechadas en los CT y ST

Centros de transfusión

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
SC (U)	**45.720**	**32.177**	**23.541**	**21.683**	**21.272**	**-1,90**
Antes de ser aptas	22.860	22.528	22.936	21.529	21.158	**-1,72**
Después de ser aptas	22.860	9.649	605	154	114	**-25,97**
CH (U)	**29.815**	**33.946**	**25.926**	**27.081**	**24.394**	**-9,92**
Antes de ser aptas	23.371	28.143	21.291	21.290	18.782	**-11,78**
Después de ser aptas	6.444	5.803	4.635	5.791	5.612	**-3,09**
PQ (DT) (ST+ Aferesis)	**5.286**	**5.788**	**5.077**	**5.420**	**4.529**	**-16,44**
PQ (DT) antes de ser aptas	**4.482**	**3.623**	**4.172**	**4.047**	**3.825**	**-5,49**
PQ (DT) antes de ser aptas procedentes de ST	3.373	2.555	3.157	3.147	2.967	**-5,72**
PQ (DT) antes de ser aptas procedentes de Aféresis	1.109	1.068	1.015	900	858	**-4,67**
PQ (DT) después de ser aptas	**804**	**2.165**	**905**	**1.373**	**704**	**-48,73**
PQ (DT) después de ser aptas procedentes de ST	570	1.867	590	1.000	526	**-47,40**
PQ (DT) después de ser aptas procedentes de Aféresis	234	298	315	373	178	**-52,28**
PFC (U)	**71.682**	**67.355**	**64.807**	**55.634**	**57.381**	**3,14**
Antes de ser aptas	52.051	49.299	48.595	41.836	40.527	**-3,13**
Después de ser aptas	19.631	18.056	16.212	13.798	16.854	**22,15**
Criop (U)	**30**	**19**	**58**	**59**	**20**	**-66,10**
Antes de ser aptas	1	9	51	54	18	**-66,67**
Después de ser aptas	29	10	7	5	2	**-60,00**
CPP (U)	**380**	**169**	**169**	**107**	**148**	**38,32**
Antes de ser aptas	59	1	57	47	15	**-68,09**
Después de ser aptas	321	168	112	60	133	**121,67**

Tabla 25. Número total de componentes sanguíneos desechados en los Centros de transfusión antes y después de ser aptos. (2021-2025)

Servicios de transfusión

	2021	2022	2023	2024	2025	% Variación 2024-2025
SC (U)	103	14	56	8	**4**	**-50,00**
CH (U)	7.857	8.233	8.692	8.291	**8.045**	**-2,97**
PQ (DT) (ST + Aféresis)	**1.517**	**2.102**	**2.161**	**1.906**	**1.749**	**-8,24**
PQ (DT) procedentes de ST	1.342	1.504	1.744	1.624	1.507	-7,20
PQ (DT) procedentes de Aféresis	175	598	417	282	242	-14,18
PFC (U)	8.088	7.798	8.101	8.040	**7.402**	**-7,94**
Criop (U)	13	20	47	36	**35**	**-2,78**
CPP (U)	13	3	2	1	**1**	**0,00**

Tabla 26. Número total de componentes sanguíneos desechados en los Servicios de Transfusión. (2021-2025)

Control de Calidad

Centros de Transfusión

Sistemas de Calidad e Inspección

Los Sistemas de Calidad deben asegurar que los productos obtenidos cumplen los requisitos previamente establecidos e incluyen un conjunto de actividades dirigidas al control directo de la calidad. La inspección es parte fundamental del procedimiento para garantizar su cumplimiento y es actividad clave de los Sistemas de Calidad.

20 CT han sido inspeccionados por la autoridad sanitaria autonómica conforme al RD 1088/2005, habiéndose efectuado 7 inspecciones durante el año 2025.

Por otro lado, los CT se someten periódicamente a certificaciones realizadas por distintos organismos, habiendo revalidado su certificación un total de 10 CT a lo largo del año 2025. De modo que, 18 CT disponen de un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015, y todos ellos siguen las Directrices de Calidad del Consejo de Europa, y además se adecuan al modelo europeo de calidad total.

Las certificaciones de los diferentes organismos obtenidas por los CT se reflejan en la siguiente tabla:

	Número de CT
Certificación Norma ISO 9001:2015 (Gestión de Calidad)	18
Acreditación Norma ISO 15189:2023 (Laboratorio) ***(Alcance de la acreditación: Toma de muestra, Inmunohematología, Biología molecular, Serología infecciosa y Cribado neonatal).***	1
Certificación CAT	10
Certificación ACSA	1

Tabla 27. Certificaciones obtenidas por los centros de transfusión. 2025

Sistemas de Identificación de Componentes Sanguíneos (CS) y Trazabilidad

Todos los CT utilizan el sistema de codificación ISBT-128, dando cobertura al 100% de las donaciones totales en España en el 2025.

20 CT garantizan la trazabilidad donante – receptor.

Servicios de Transfusión

El 79,01% de los ST han sido inspeccionados por la autoridad sanitaria de la CA correspondiente, habiéndose inspeccionado 103 Servicios (20,40%) durante el transcurso del año 2025.

El 79,01% de los ST disponen de un Sistema de Gestión de la Calidad, que incluye procedimientos normalizados de trabajo. En el 64,41% se trata del Sistema ISO 9001:2015 y 108 Servicios (21,39%) indican que han sido certificados por el CAT. A lo largo del año 2025, un total de 130 Servicios (25,74%) han sido certificados.

En 442 hospitales existe CHT (87,52%) siendo la media del número de reuniones de 2,36. El 16,44% de hospitales no disponen de CHT y el 24,36% de hospitales, aun teniendo dicho Comité, han celebrado menos de 2 reuniones al año.

474 hospitales tienen implantado un sistema de Hemovigilancia (93,86%), y de estos, 388 cuentan con personal específicamente asignado a esta tarea. El 88,91% de ST disponen de aplicación informática específica para el control transfusional, el 91,68% tienen implantado algún tipo de sistema de seguridad para evitar errores en la administración de componentes y el 95,84% disponen de una guía clínica para la transfusión de componentes sanguíneos.

Anexo. Indicadores por CCAA

(Año 2025)

Donaciones

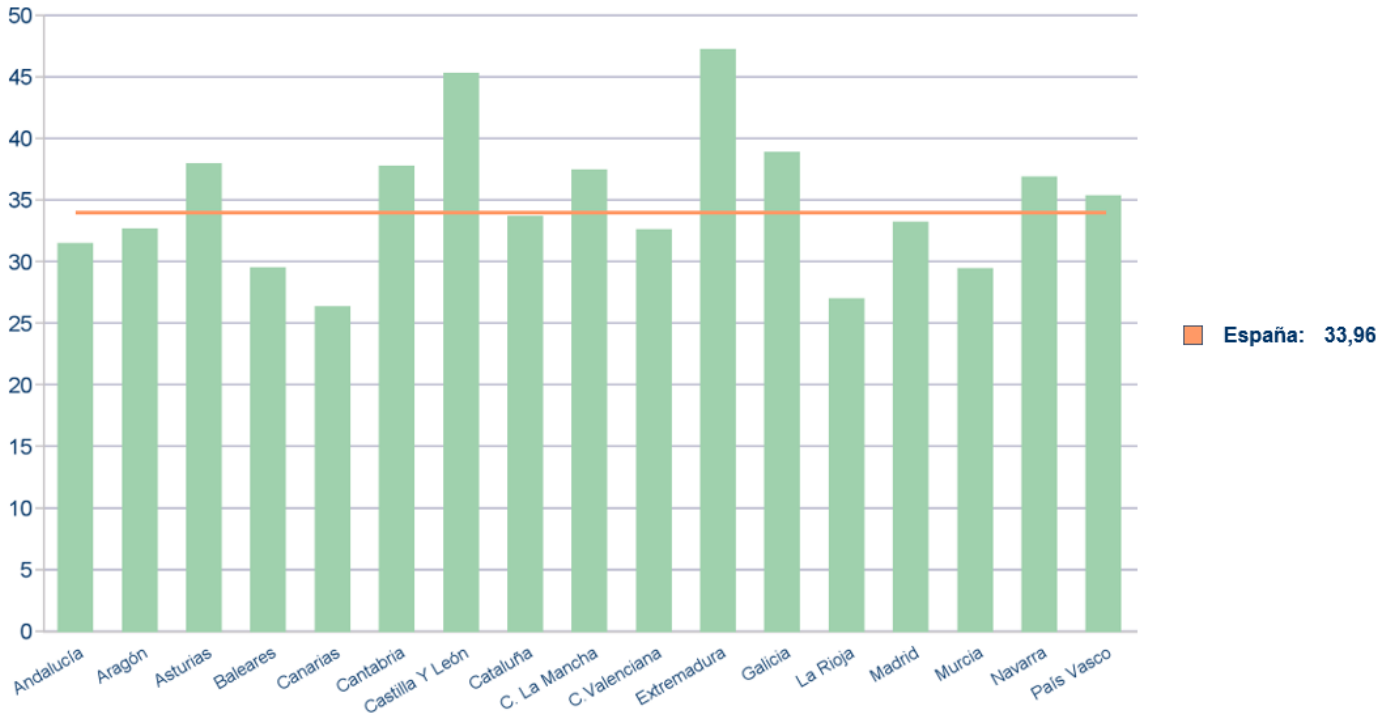


Gráfico 15. Índices de donación nacional y autonómicos. 2025

Obtención de componentes sanguíneos

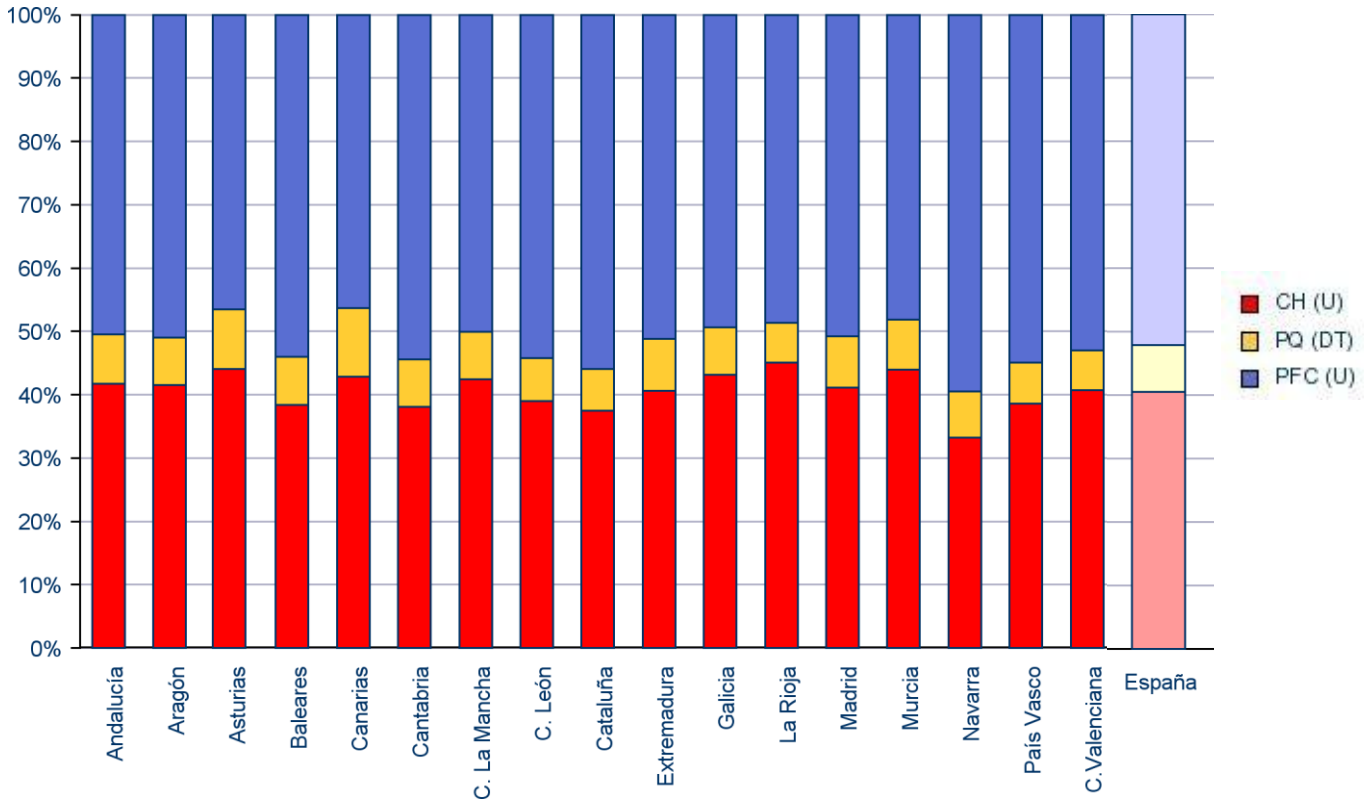


Gráfico 16. Distribución porcentual de obtención de los principales componentes sanguíneos en España y por CCAA. 2025

Obtención de componentes sanguíneos

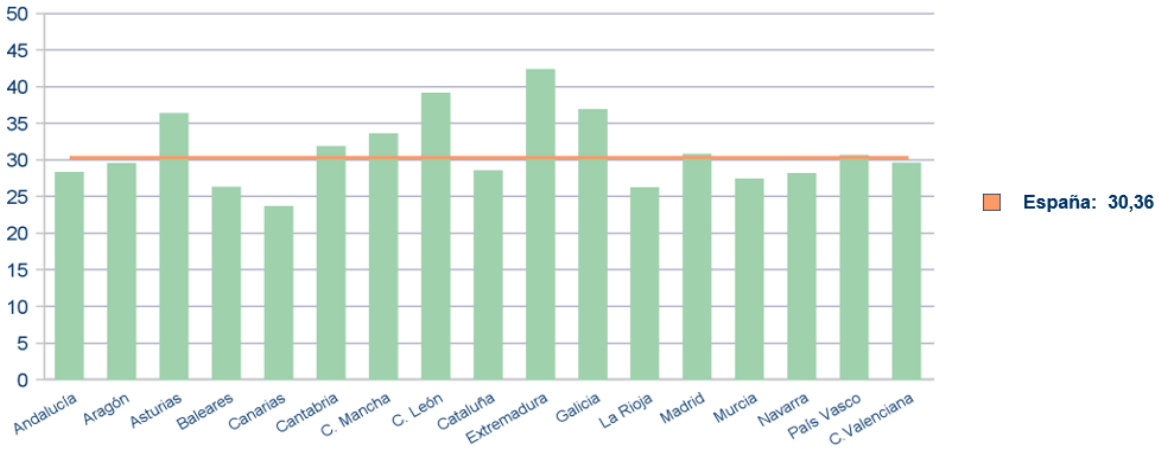


Gráfico 17. Índices nacional y autonómicos de obtención de unidades de hematíes por 1.000 habitantes. 2025

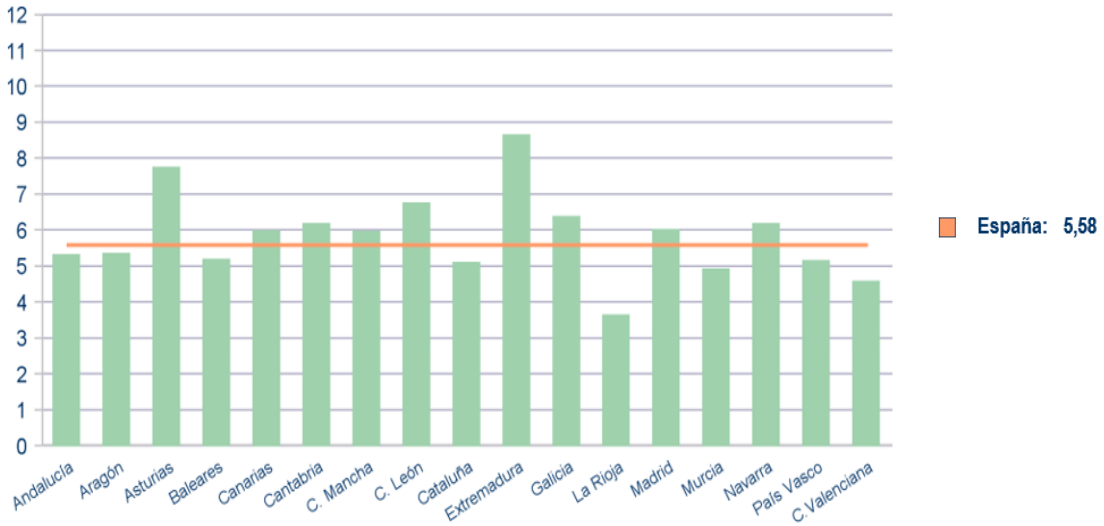


Gráfico 18. Índices nacional y autonómicos de obtención de dosis terapéuticas de plaquetas por 1.000 habitantes. 2025

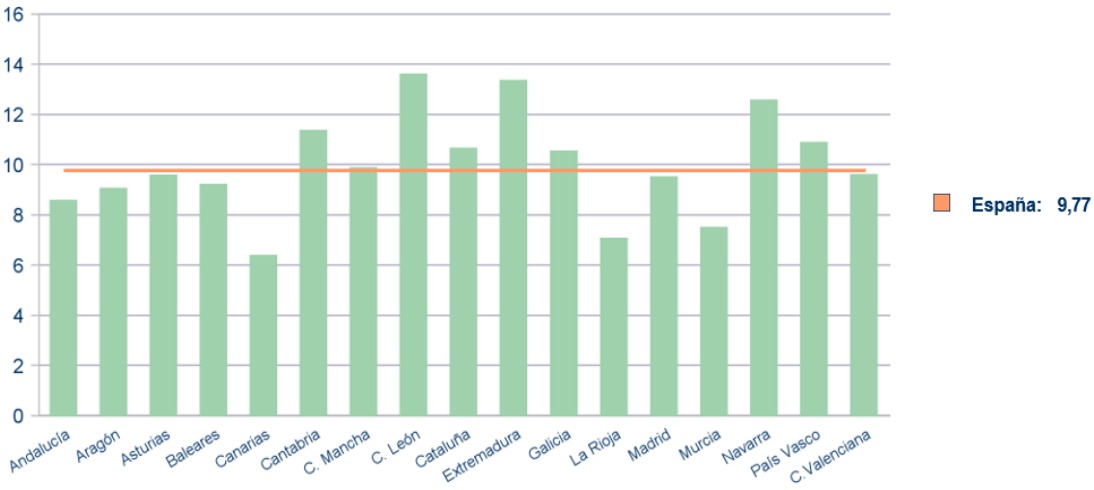


Gráfico 19. Índices nacional y autonómicos de obtención de litros de plasma por 1.000 habitantes. 2025

Plasma

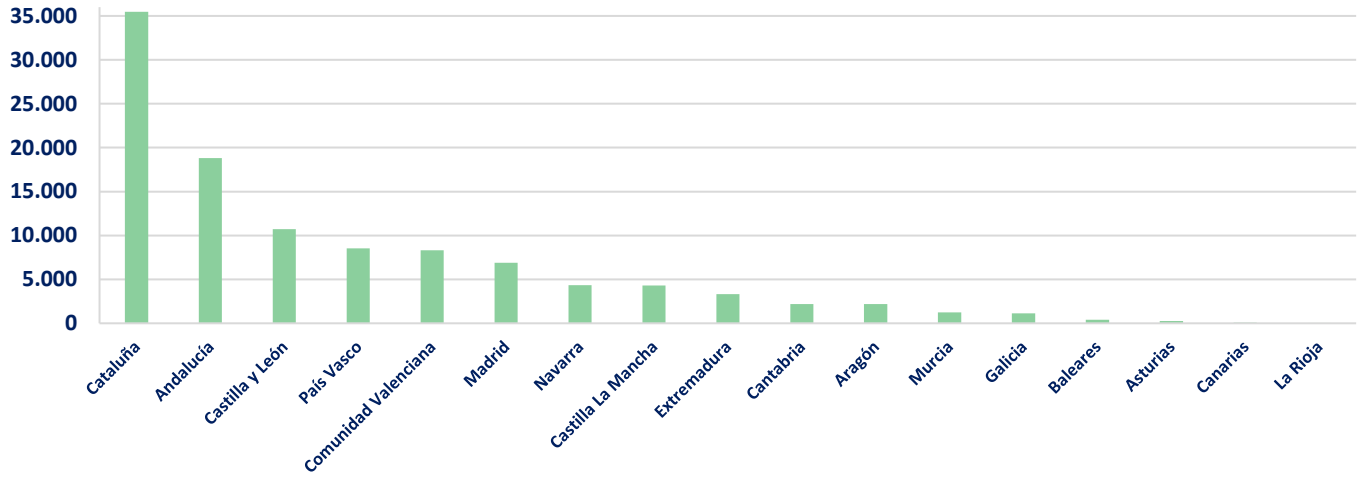


Gráfico 20. Número de procesos de plasmaféresis realizados. 2025

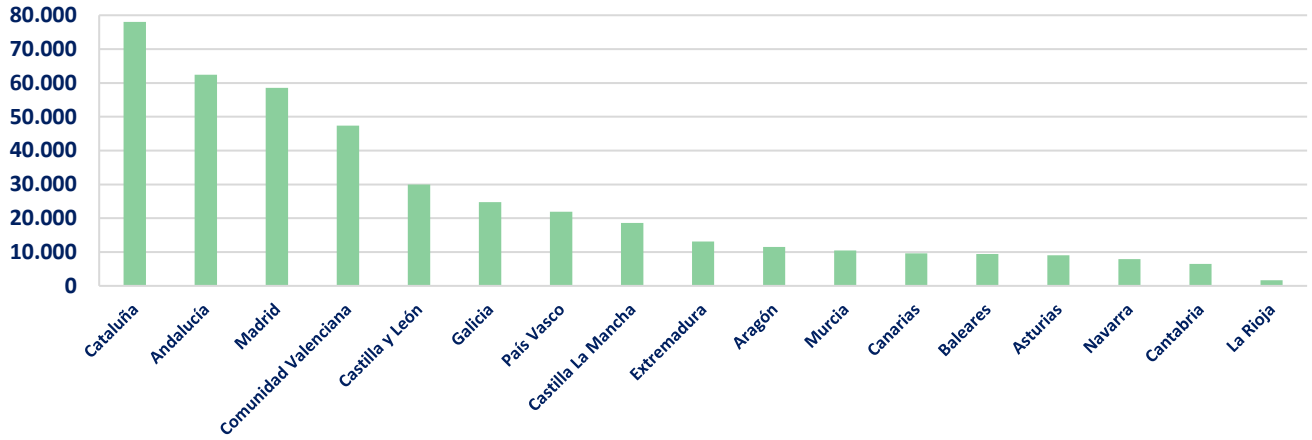


Gráfico 21. Plasma total enviado a la industria fraccionadora (L). 2025

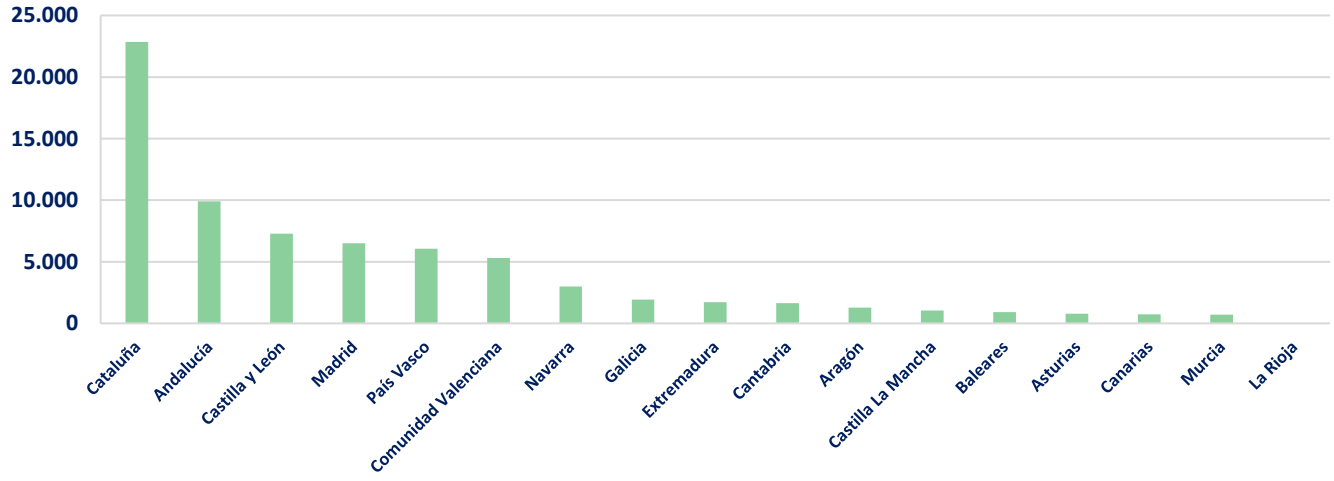


Gráfico 22. Plasma total enviado a la industria fraccionadora procedente de aféresis (L). 2025

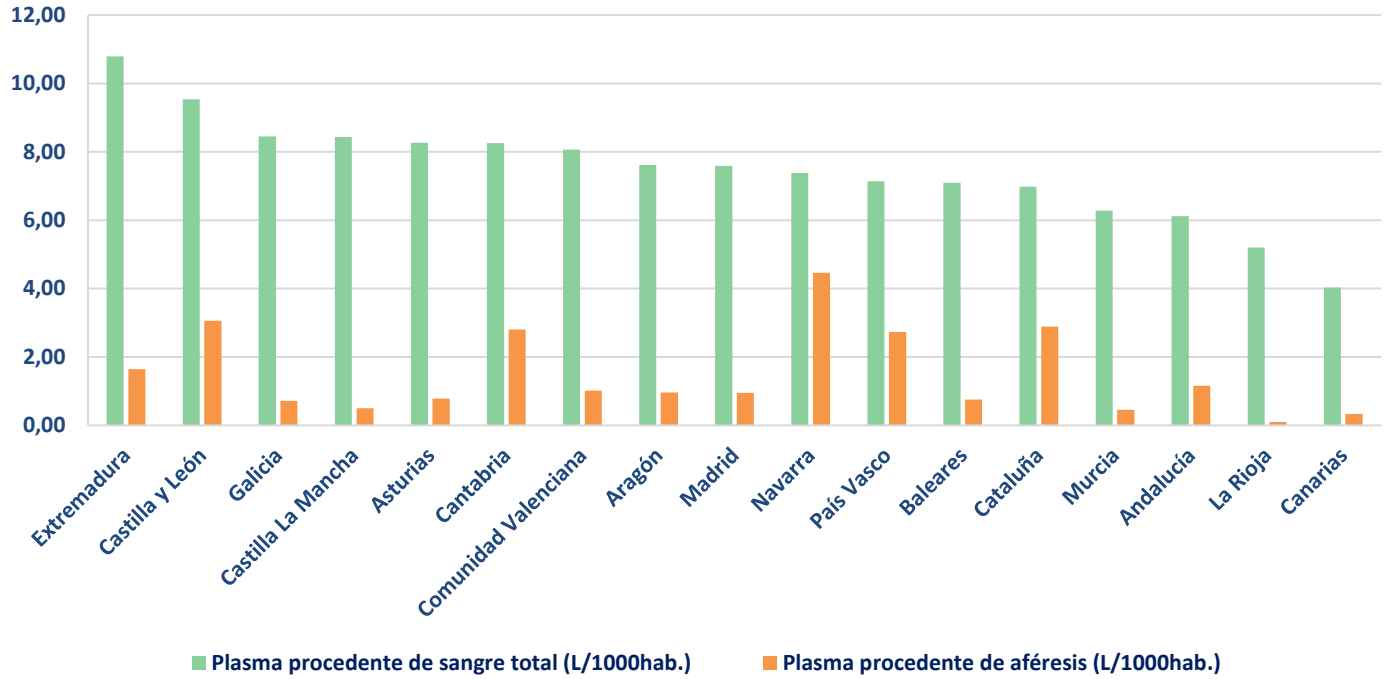


Gráfico 23. Tasa de plasma enviado a la industria fraccionadora según procedencia (L por 1.000 habitantes)

Transfusión

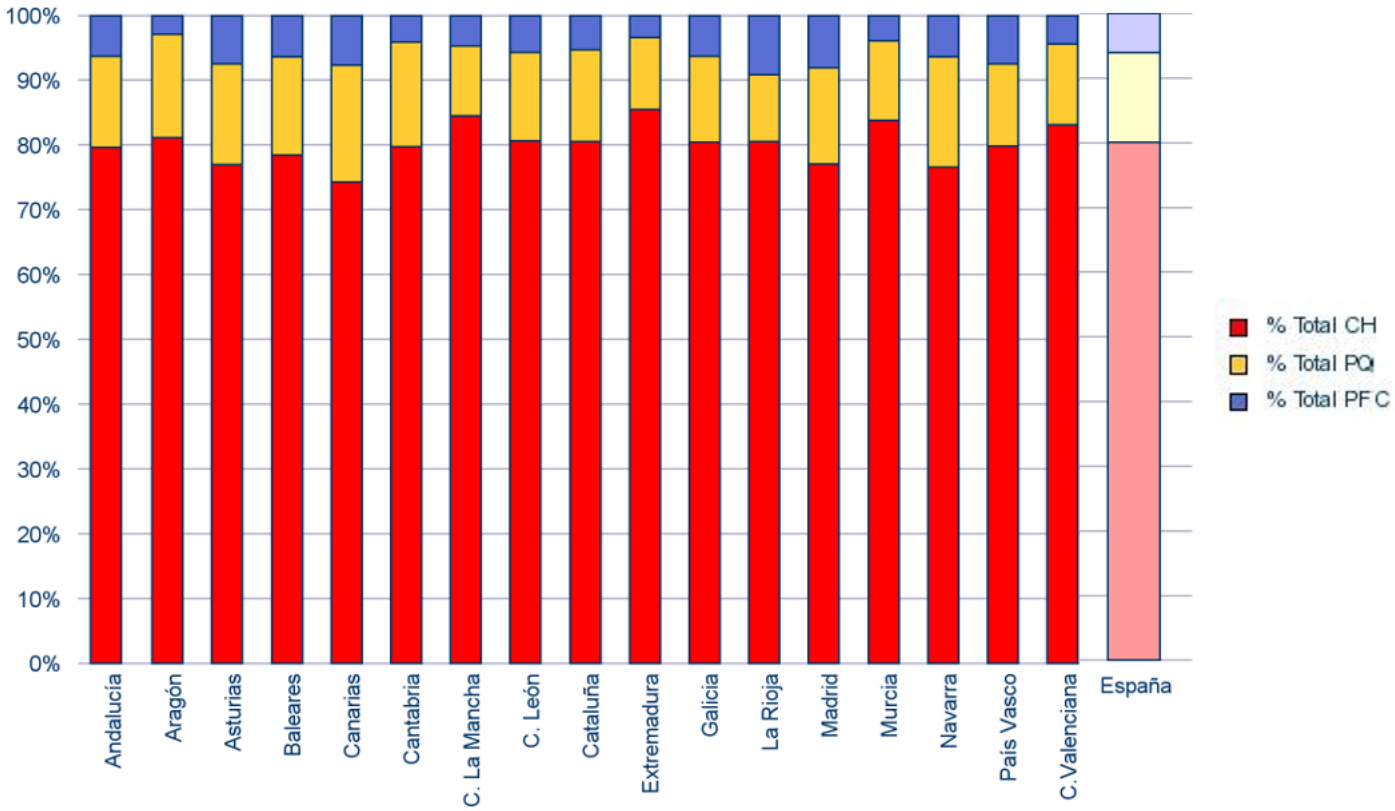


Gráfico 24. Distribución porcentual de transfusión de los principales componentes sanguíneos en España y por CCAA. 2025

Transfusión

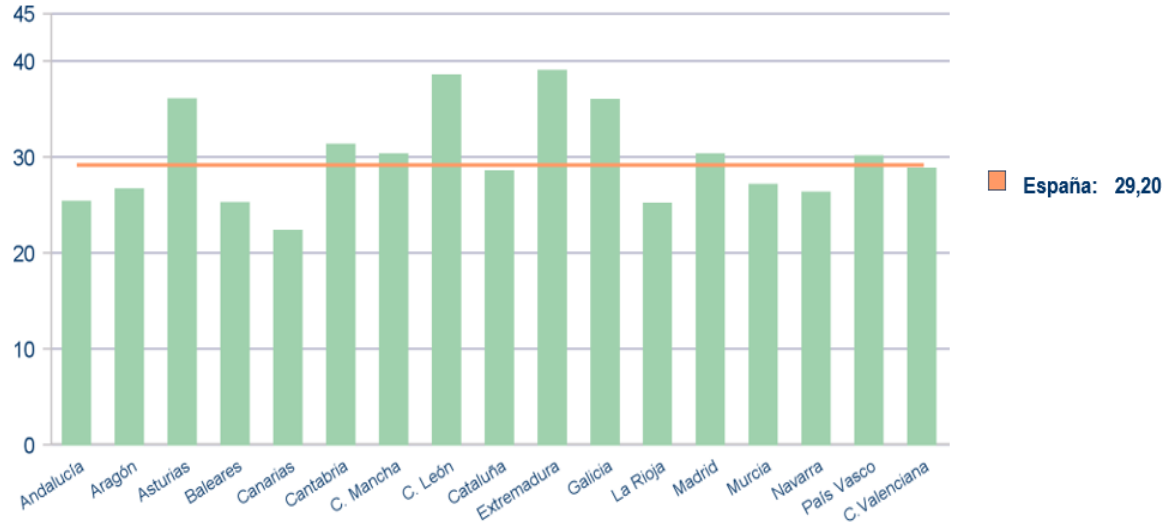


Gráfico 25. Índices nacional y autonómicos de transfusión de unidades de hematíes por 1.000 habitantes. 2025

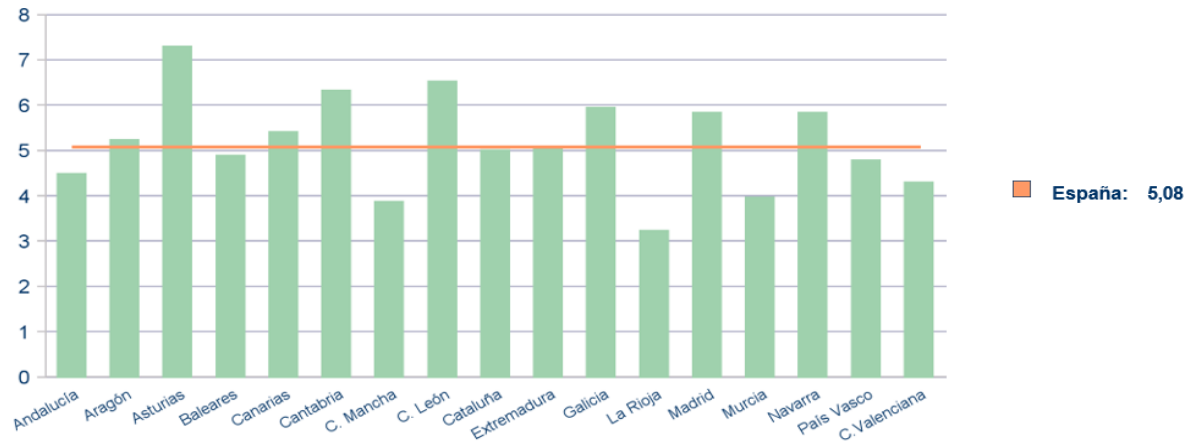


Gráfico 26. Índices nacional y autonómicos de transfusión de dosis terapéuticas de plaquetas por 1.000 habitantes. 2025

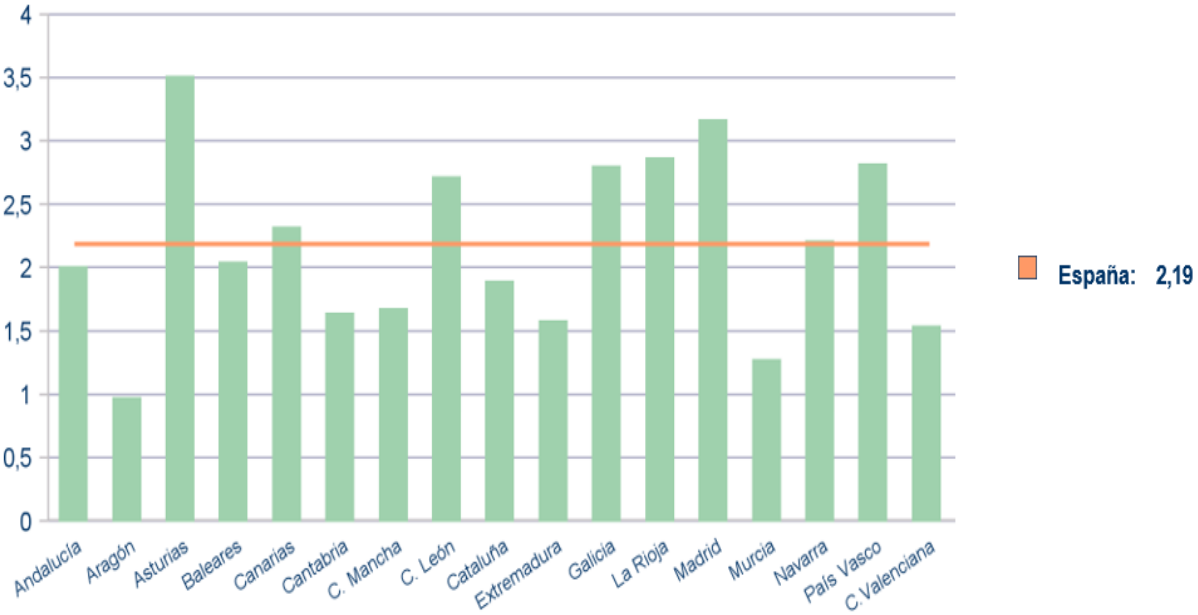


Gráfico 27. Índices nacional y autonómicos de transfusión de unidades de plasma por 1.000 habitantes. 2025

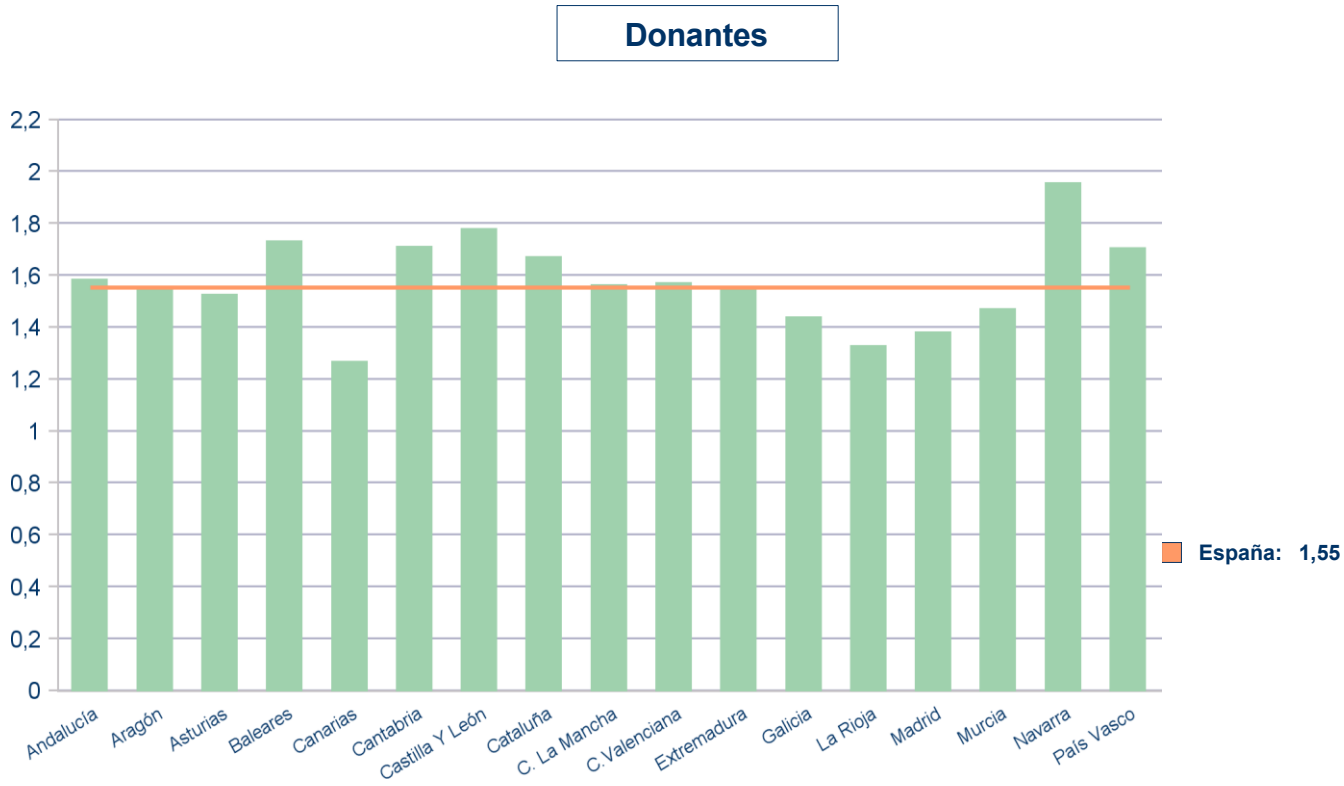


Gráfico 28. Números de donaciones realizadas por donante nacional y autonómicos. 2025

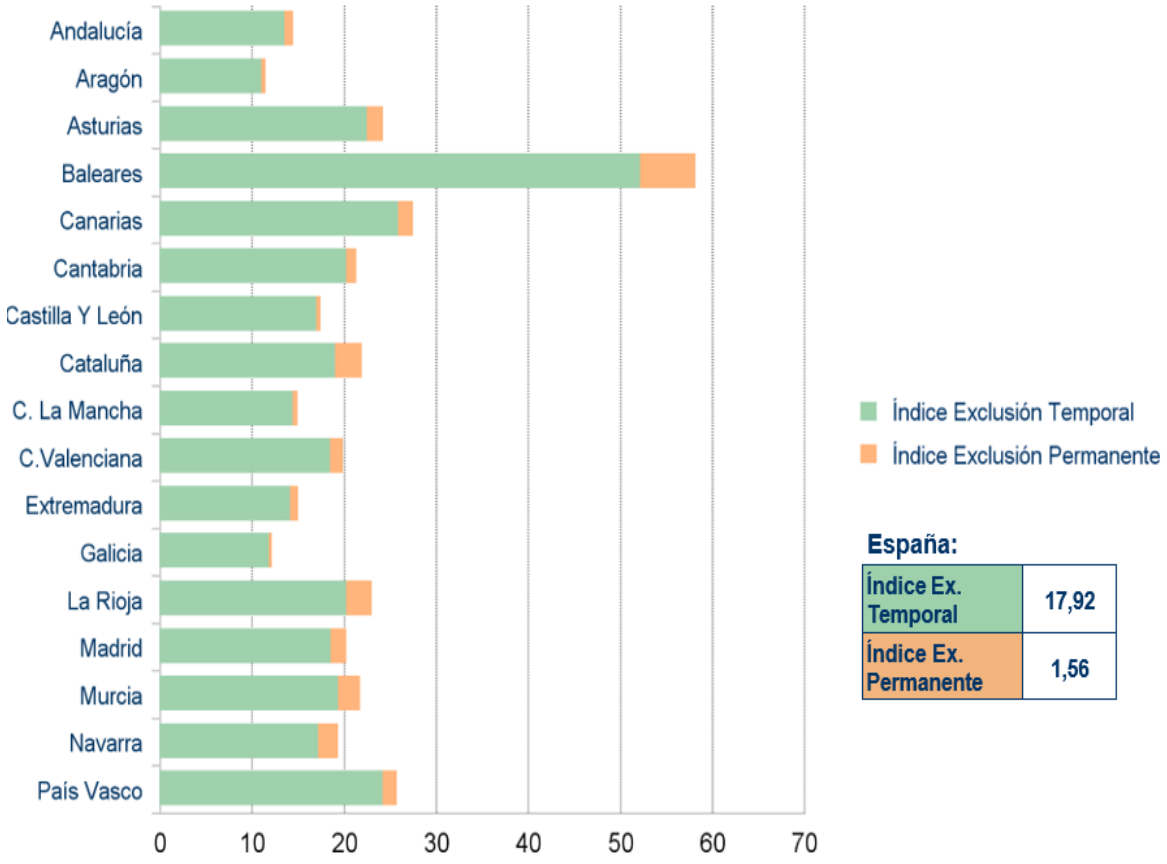


Gráfico 29. Índices de exclusión temporal y exclusión permanente nacionales y autonómicos. 2025

Laboratorio: Marcador Obligatorio VIH

Andalucía

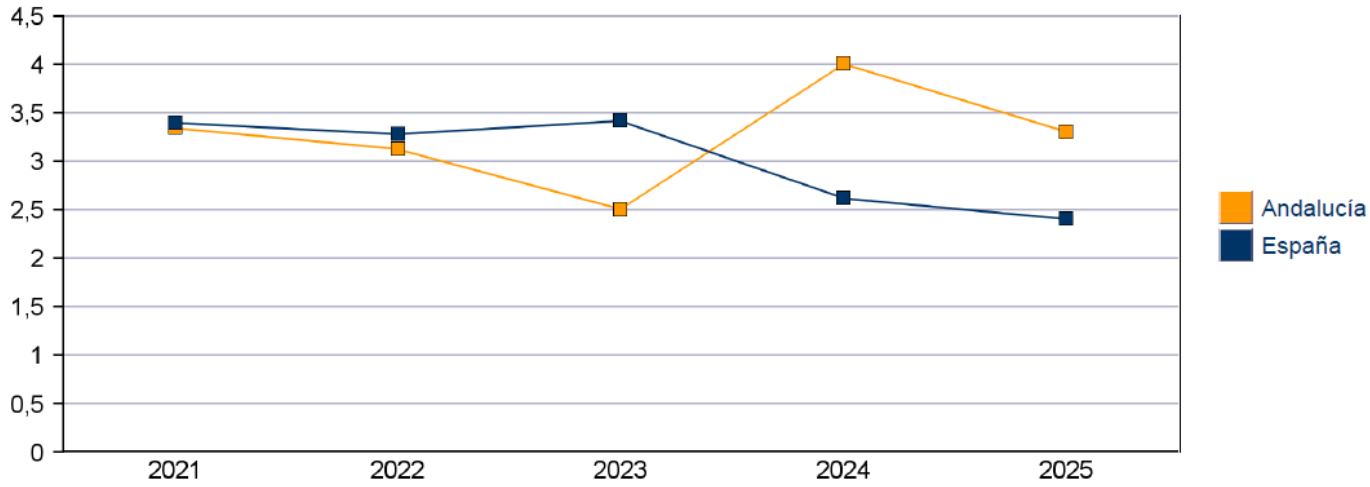


Gráfico 30. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Andalucía. (2021-2025)

Aragón

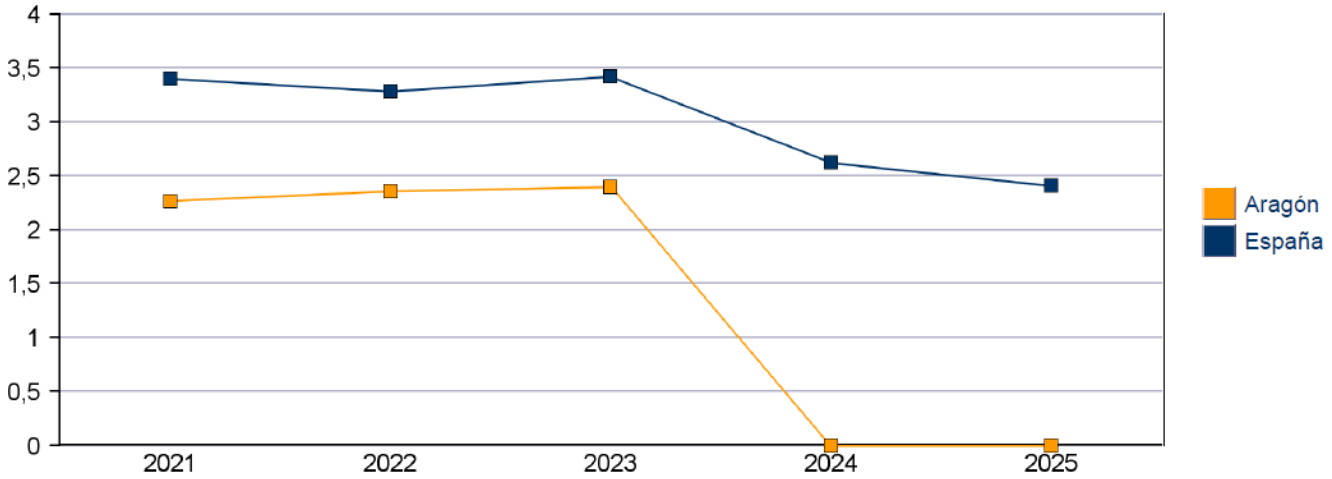


Gráfico 31. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Aragón. (2021-2025)

Asturias

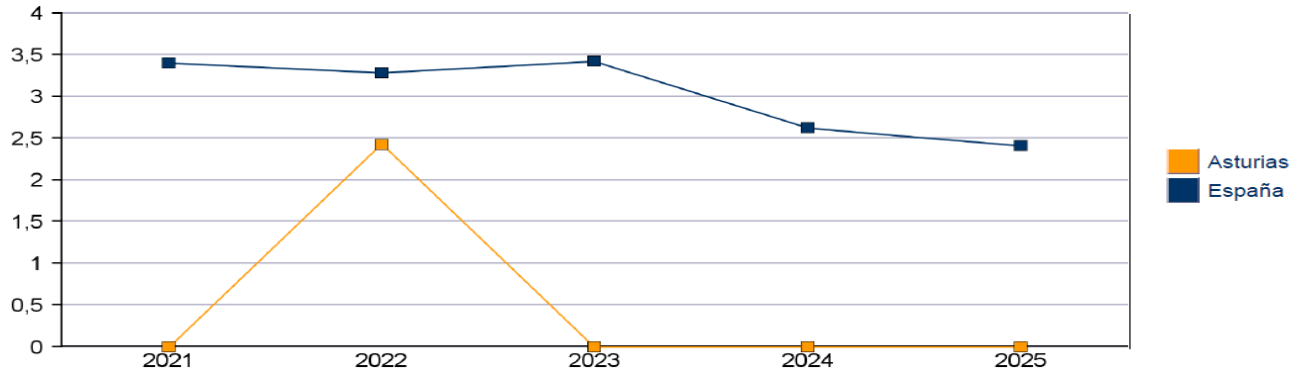


Gráfico 32. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Asturias. (2021-2025)

Baleares

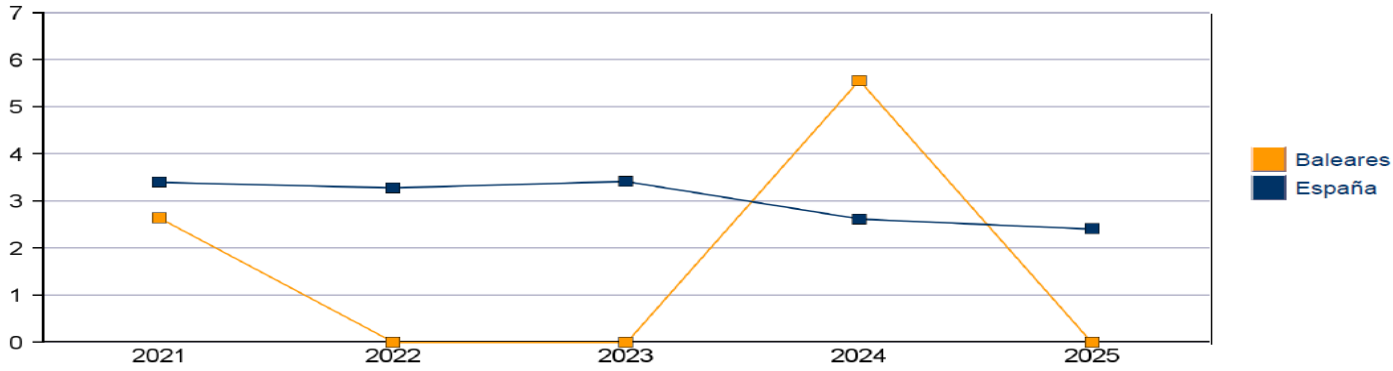


Gráfico 33. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Baleares. (2021-2025)

Canarias

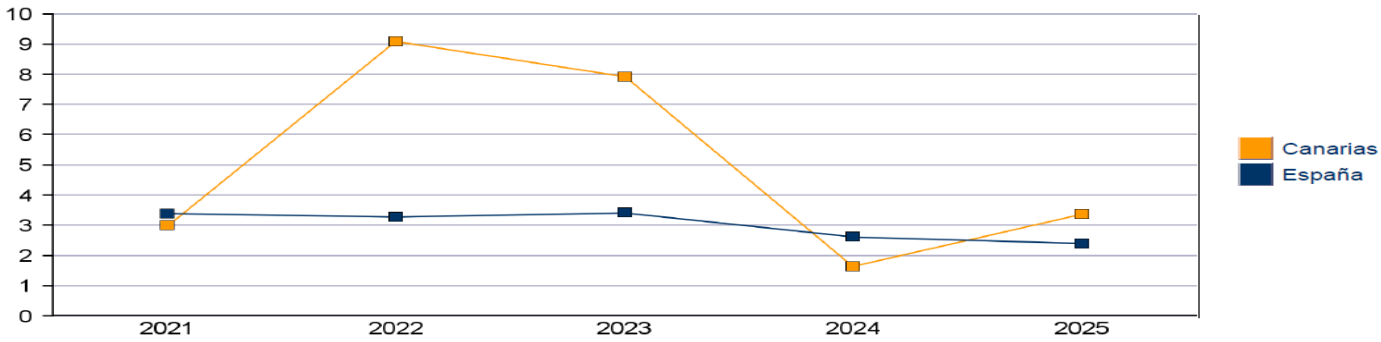


Gráfico 34. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Canarias. (2021-2025)

Cantabria

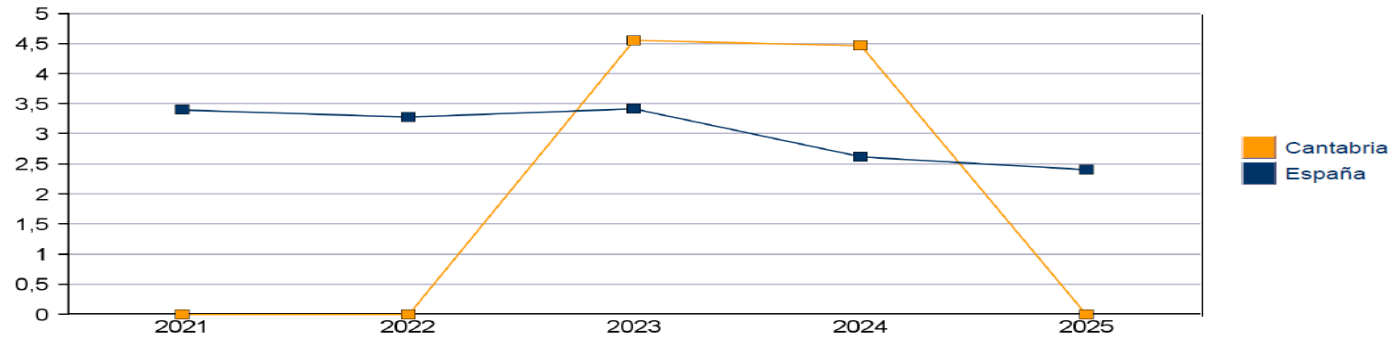


Gráfico 35. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Cantabria. (2021-2025)

Castilla La Mancha

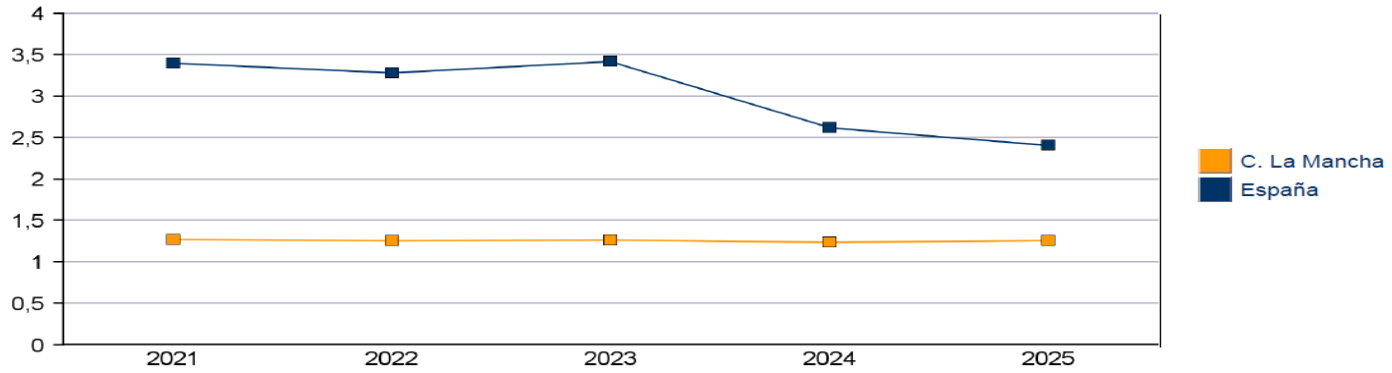


Gráfico 36. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Castilla – La Mancha. (2021-2025)

Castilla Y León

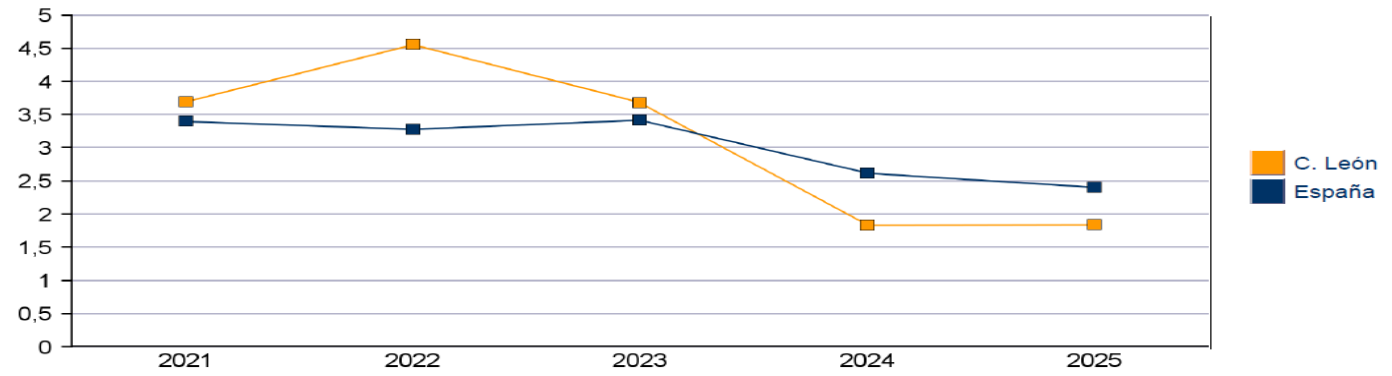


Gráfico 37. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Castilla y León. (2021-2025)

Cataluña

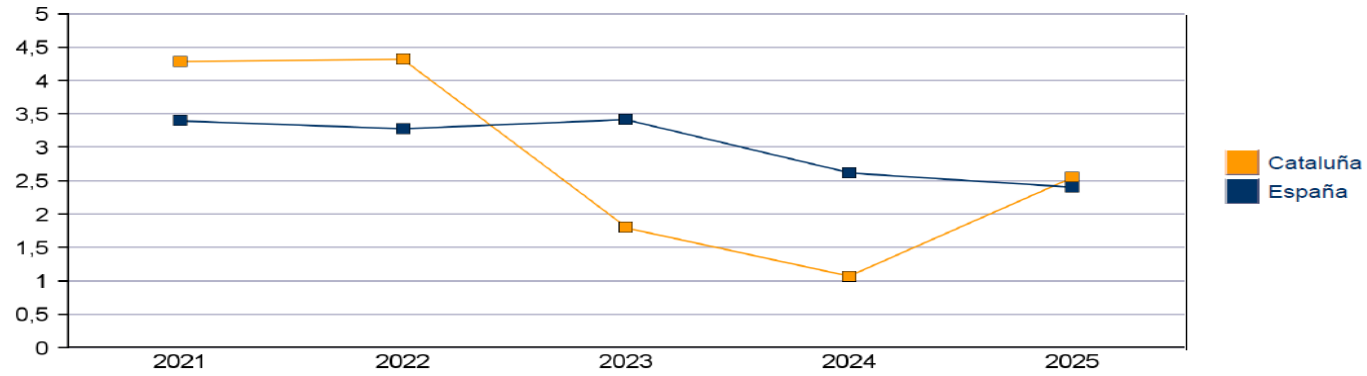


Gráfico 38. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Cataluña. (2021-2025)

Comunidad Valenciana

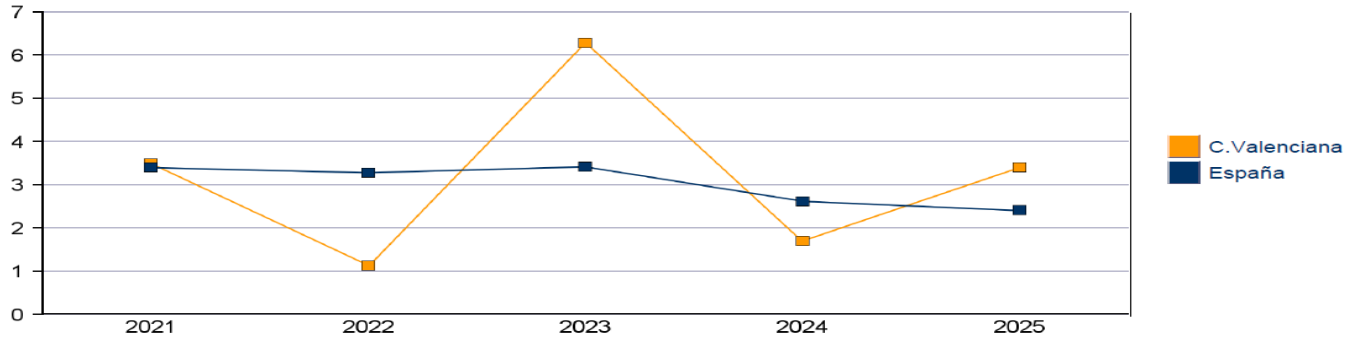


Gráfico 39. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Comunidad Valenciana. (2021-2025)

Extremadura

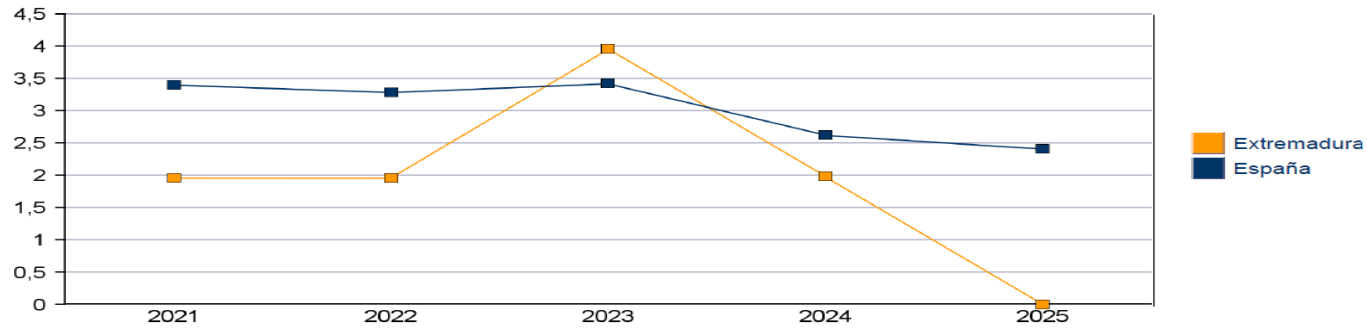


Gráfico 40. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Extremadura. (2021-2025)

Galicia

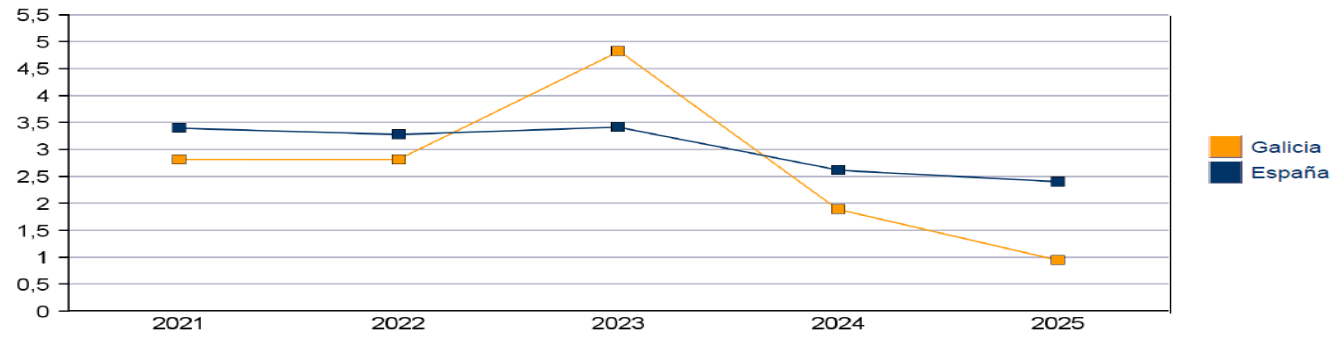


Gráfico 41. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Galicia. (2021-2025)

La Rioja

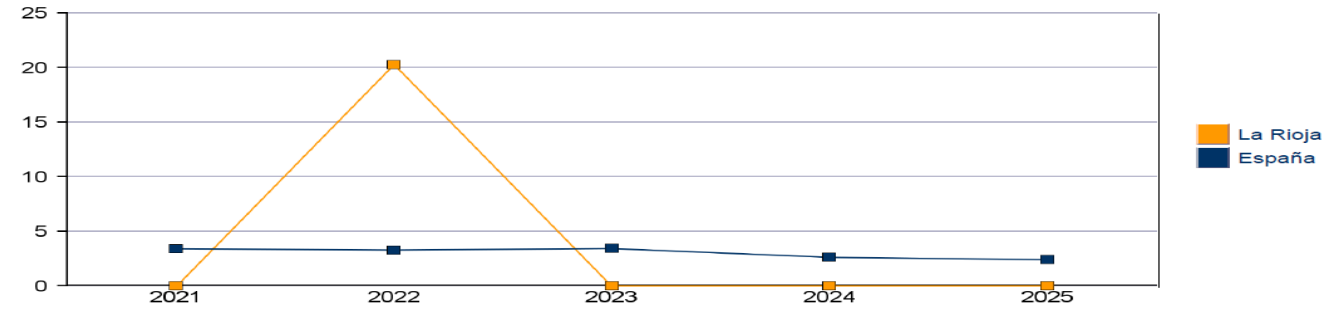


Gráfico 42. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. La Rioja. (2021-2025)

Madrid

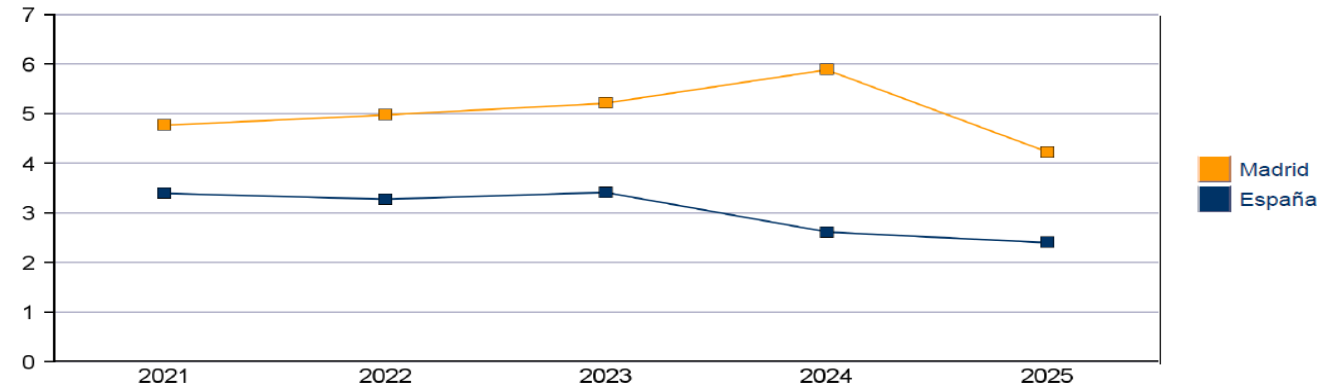


Gráfico 43. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Madrid. (2021-2025)

Murcia

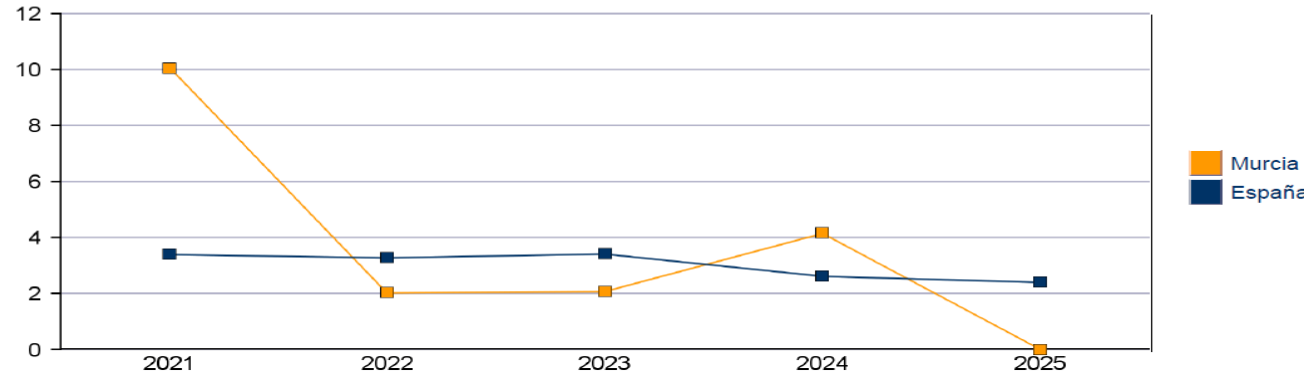


Gráfico 44. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Murcia. (2021-2025)

Navarra

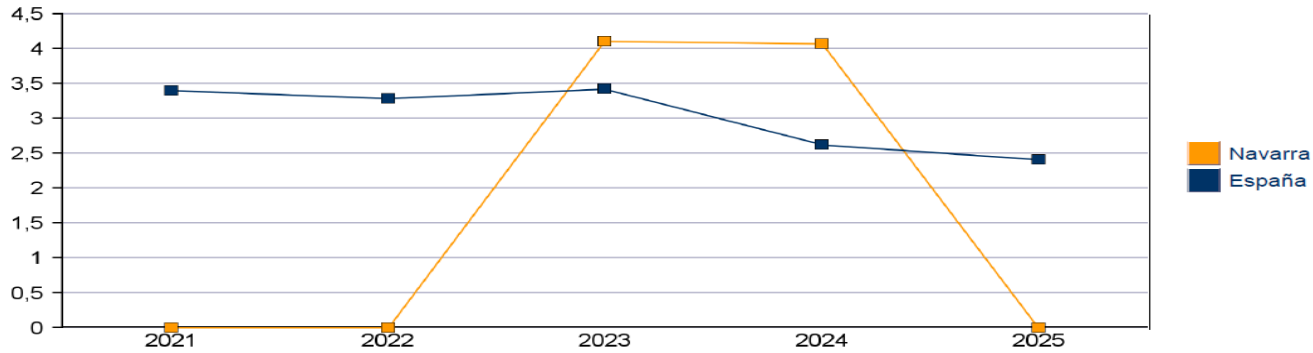


Gráfico 45. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. Navarra. (2021-2025)

País Vasco

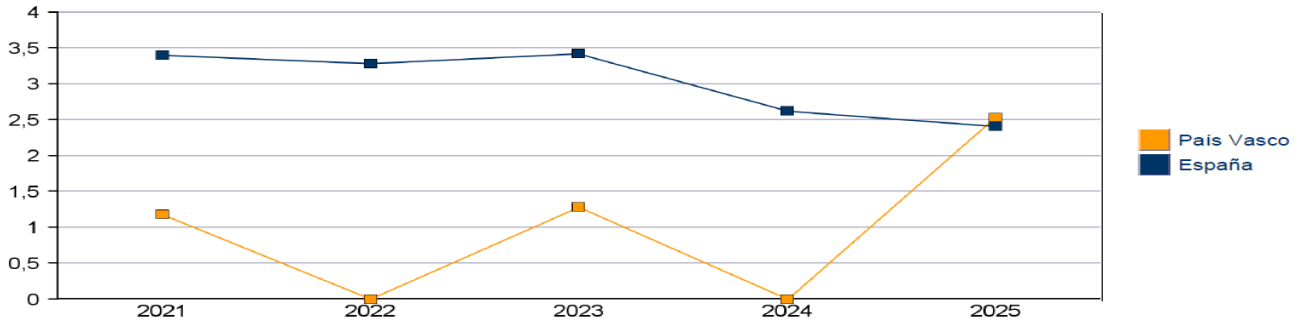


Gráfico 46. Marcadores Obligatorios: VIH. Prevalencia por 100.000 donaciones. País Vasco. (2021-2025)

Laboratorio: Marcador Obligatorio VHC

Andalucía

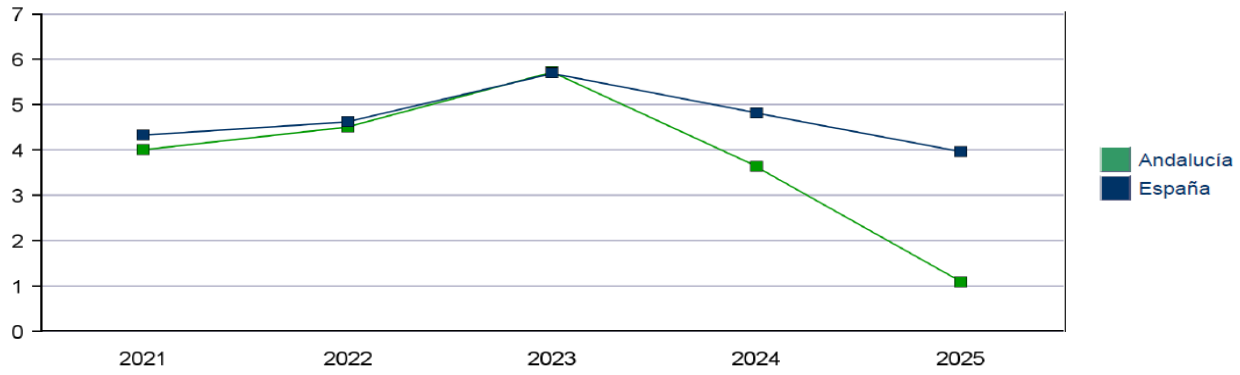


Gráfico 47. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Andalucía. (2021-2025)

Aragón

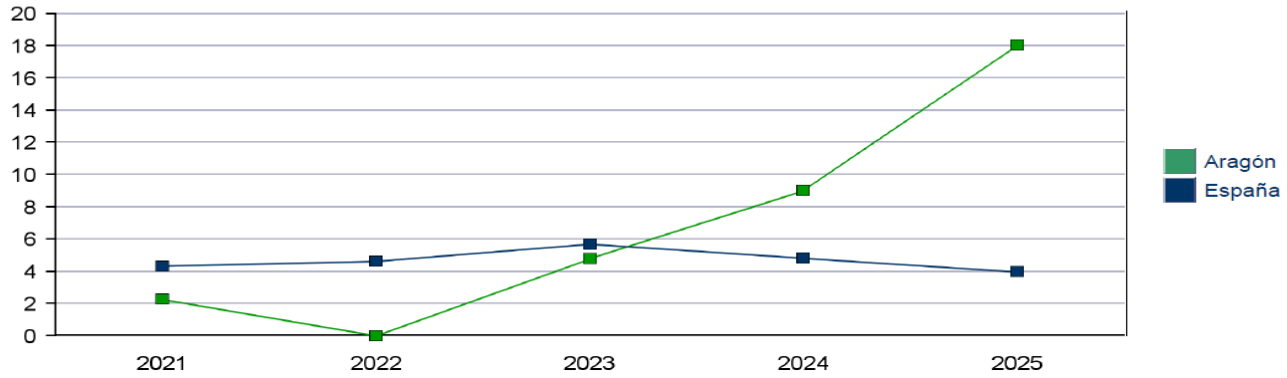


Gráfico 48. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Aragón. (2021-2025)

Asturias

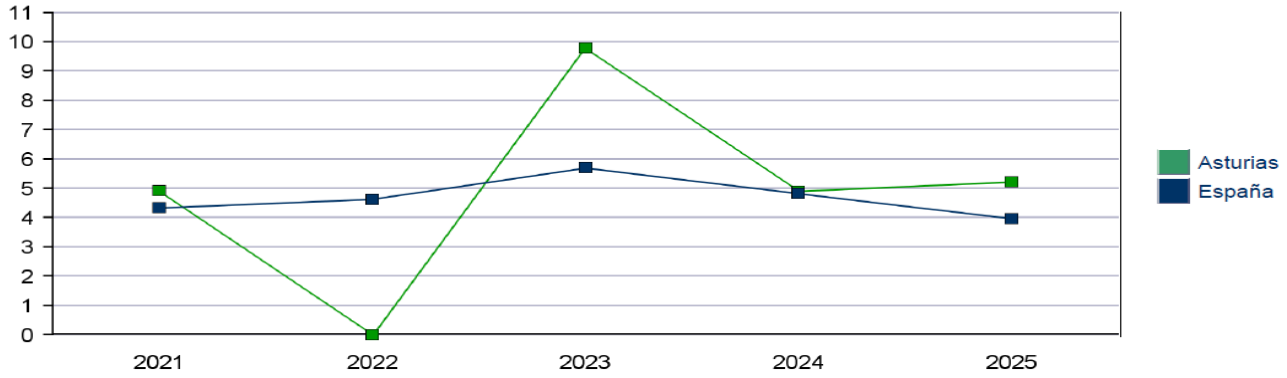


Gráfico 49. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Asturias. (2021-2025)

Baleares

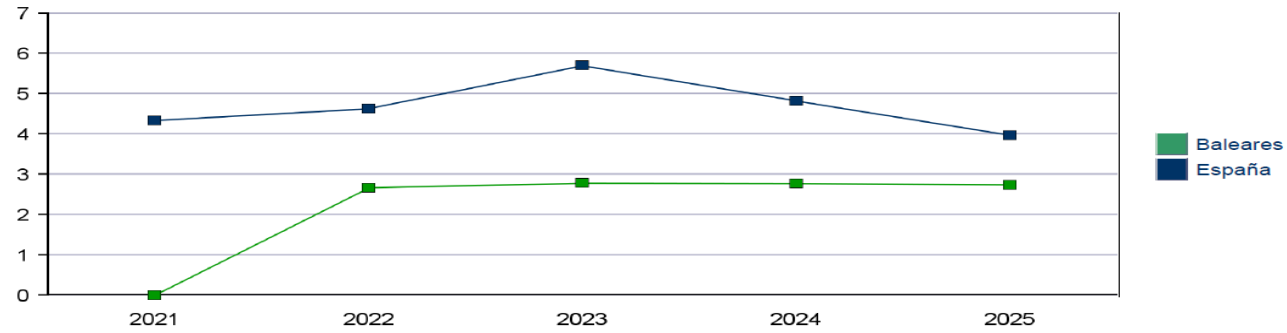


Gráfico 50. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Baleares. (2021-2025)

Canarias

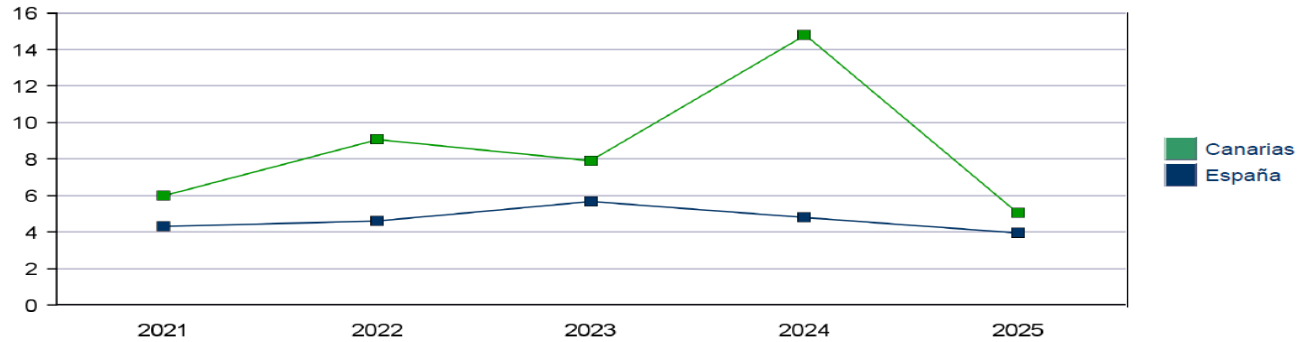


Gráfico 51. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Canarias. (2021-2025)

Cantabria

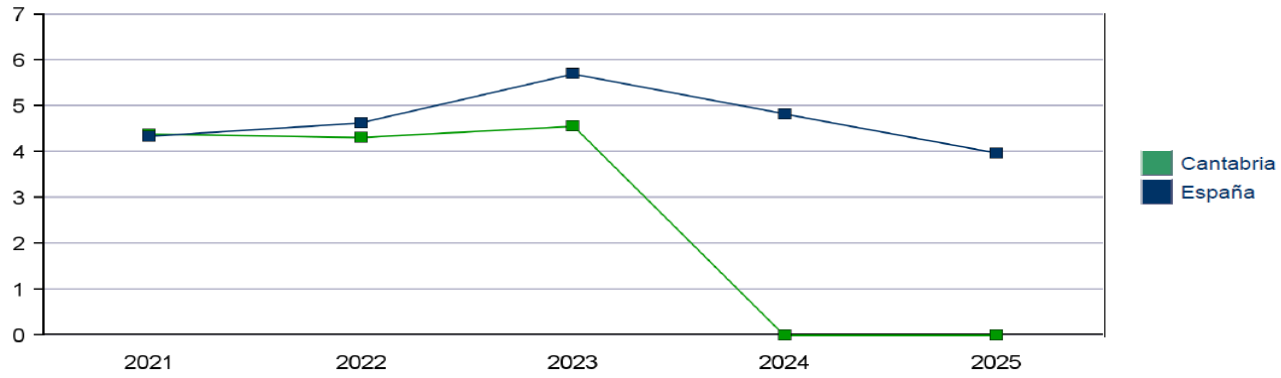


Gráfico 52. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Cantabria. (2021-2025)

Castilla La Mancha

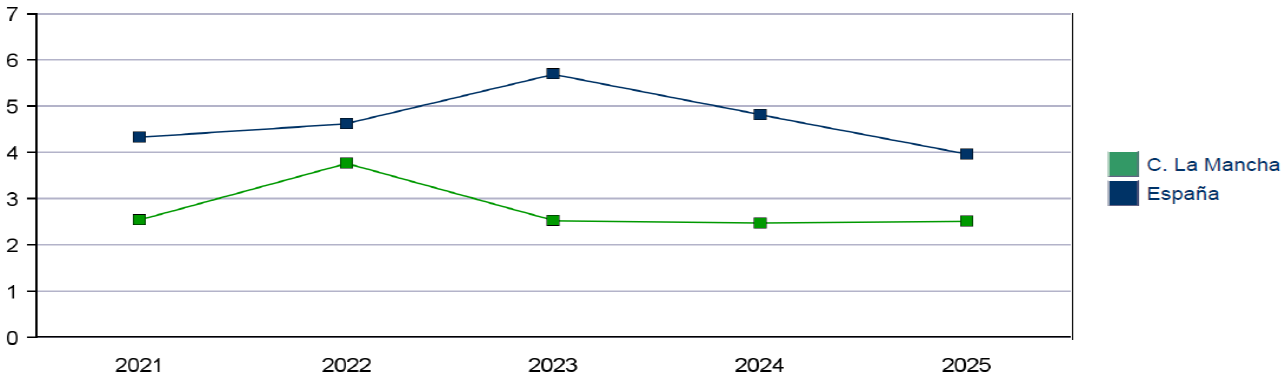


Gráfico 53. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Castilla–La Mancha. (2021-2025)

Castilla Y León

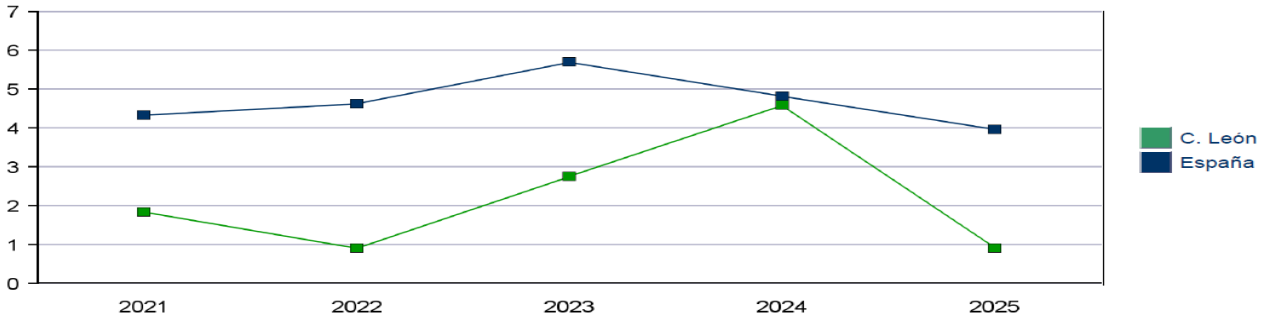


Gráfico 54. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Castilla y León. (2021-2025)

Cataluña

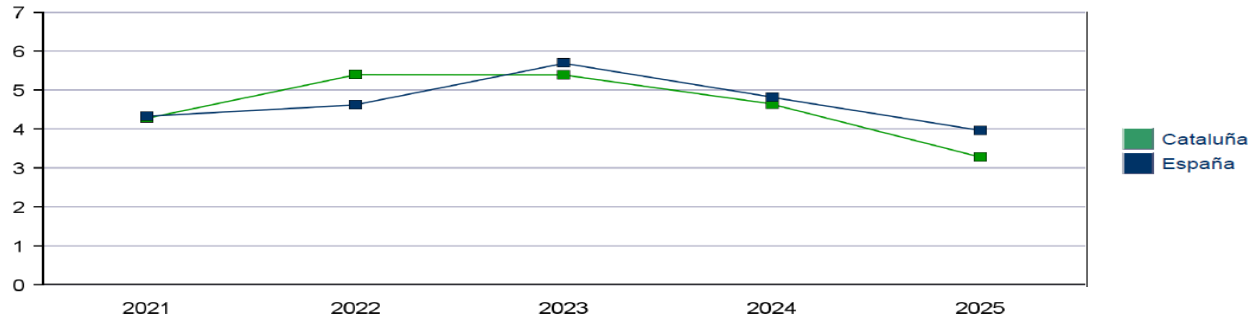


Gráfico 55. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Cataluña. (2021-2025)

Comunidad Valenciana

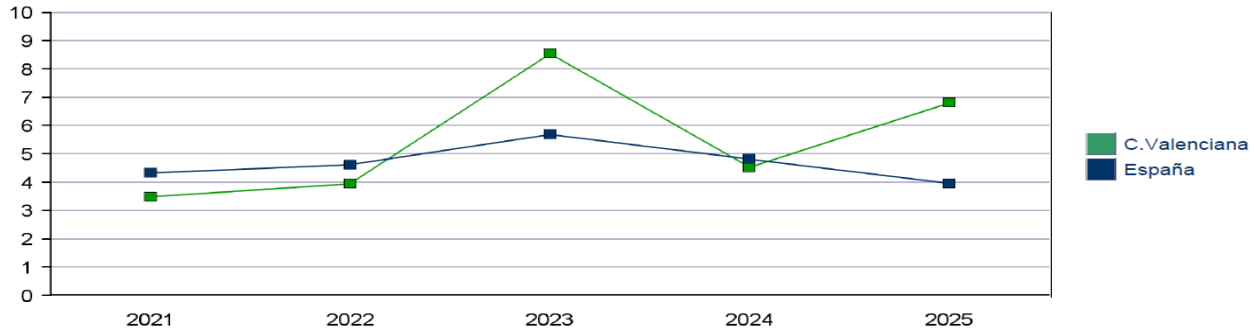


Gráfico 56. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Comunidad Valenciana. (2021-2025)

Extremadura

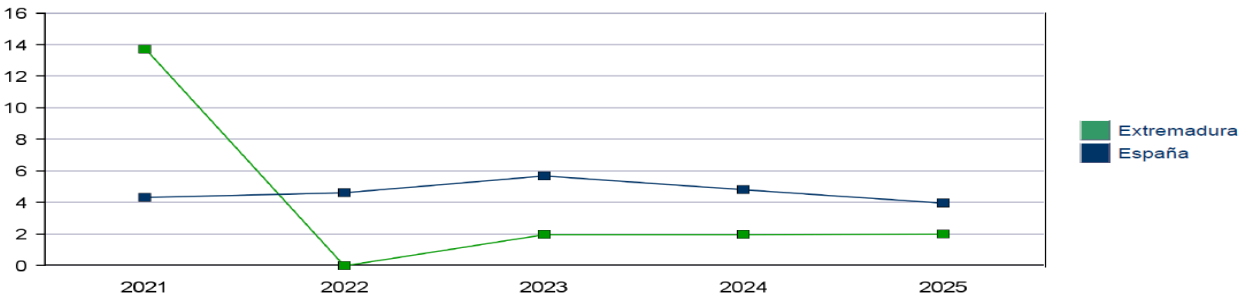


Gráfico 57. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Extremadura. (2021-2025)

Galicia

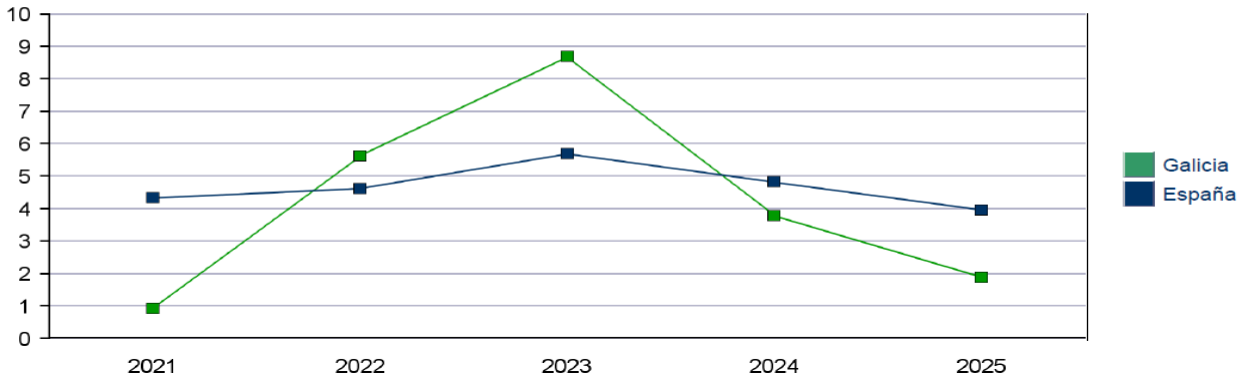


Gráfico 58. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Galicia. (2021-2025)

La Rioja

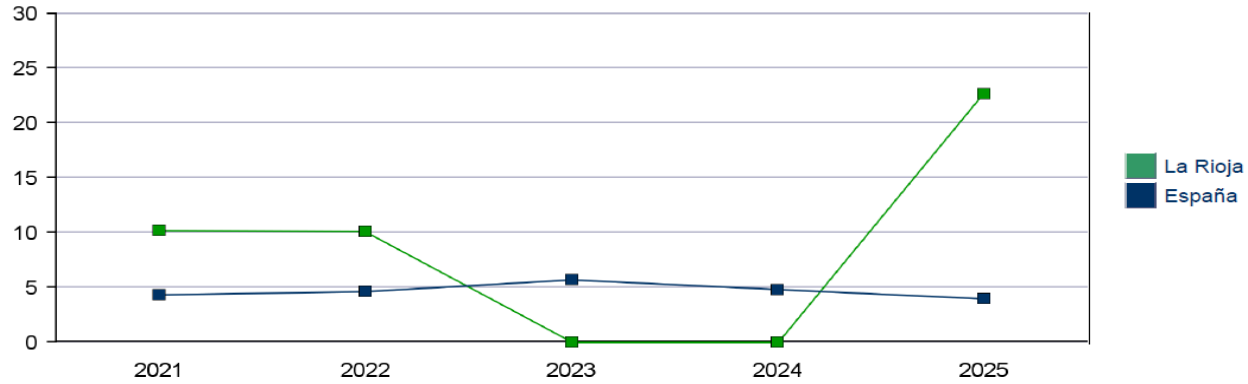


Gráfico 59. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. La Rioja. (2021-2025)

Madrid

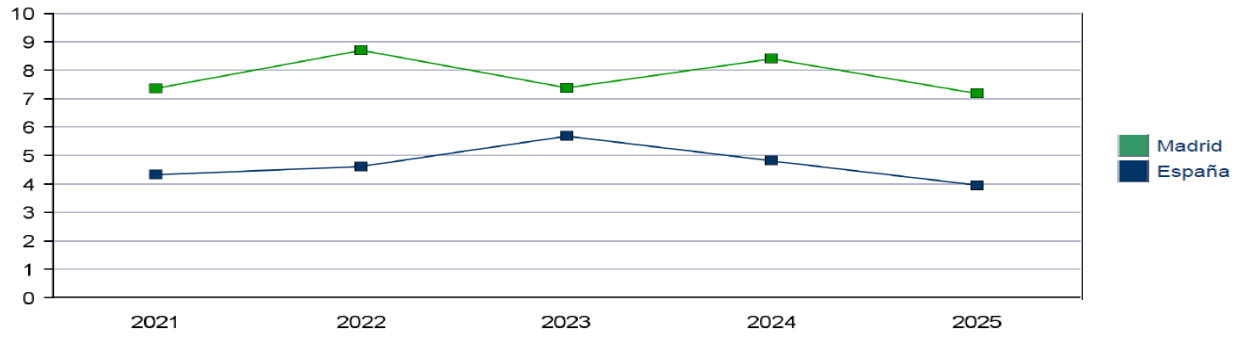


Gráfico 60. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Madrid. (2021-2025)

Murcia

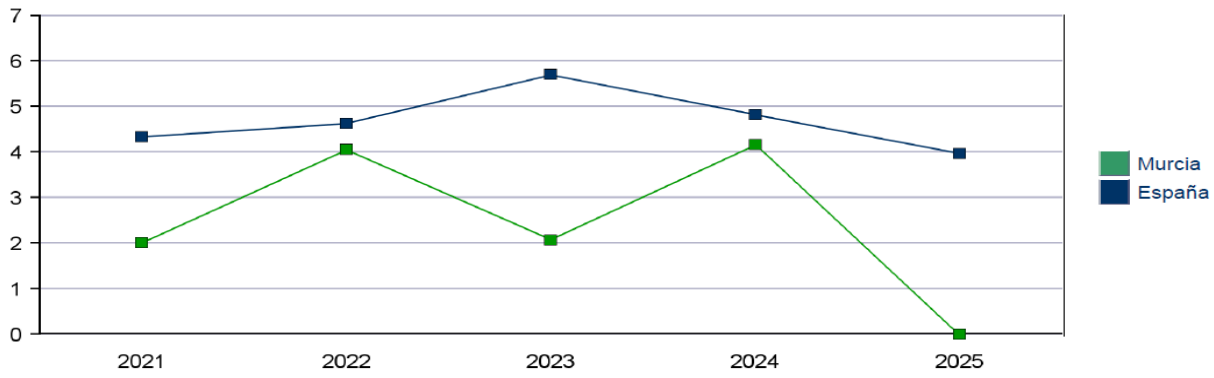


Gráfico 61. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Murcia. (2021-2025)

Navarra

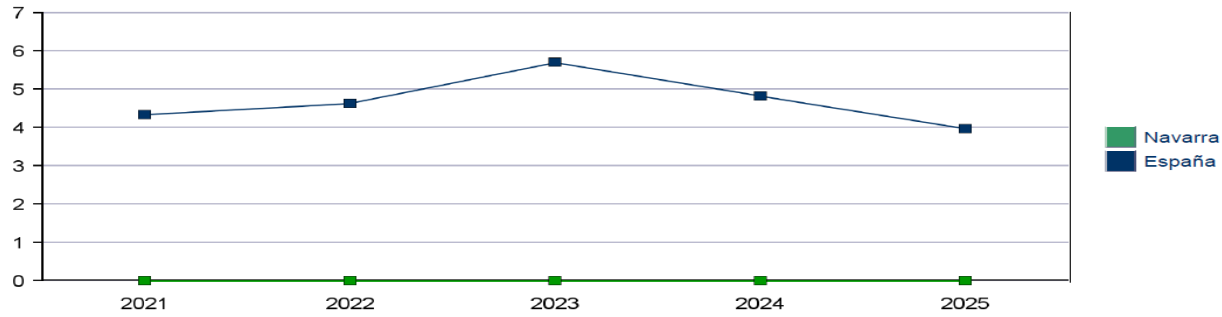


Gráfico 62. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. Navarra. (2021-2025)

País Vasco

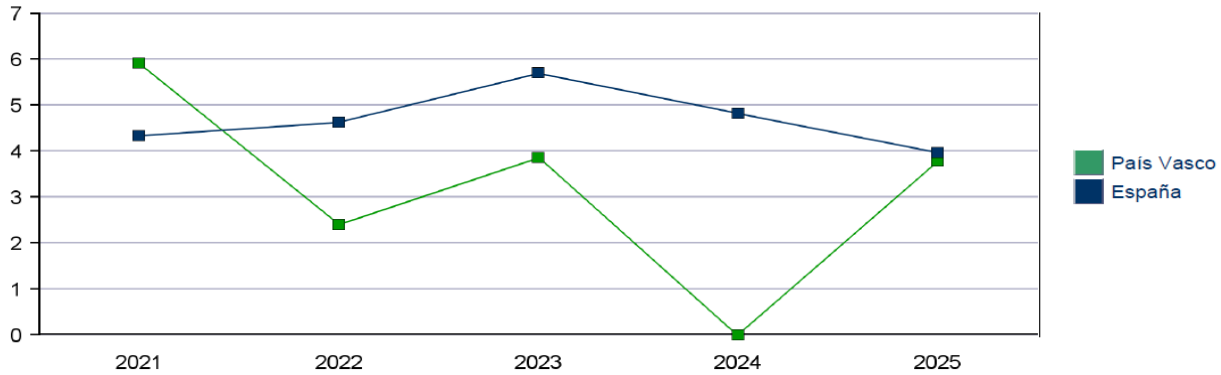


Gráfico 63. Marcadores Obligatorios: VHC. Prevalencia por 100.000 donaciones. País Vasco. (2021-2025)

Laboratorio: Marcador Obligatorio VHB

Andalucía

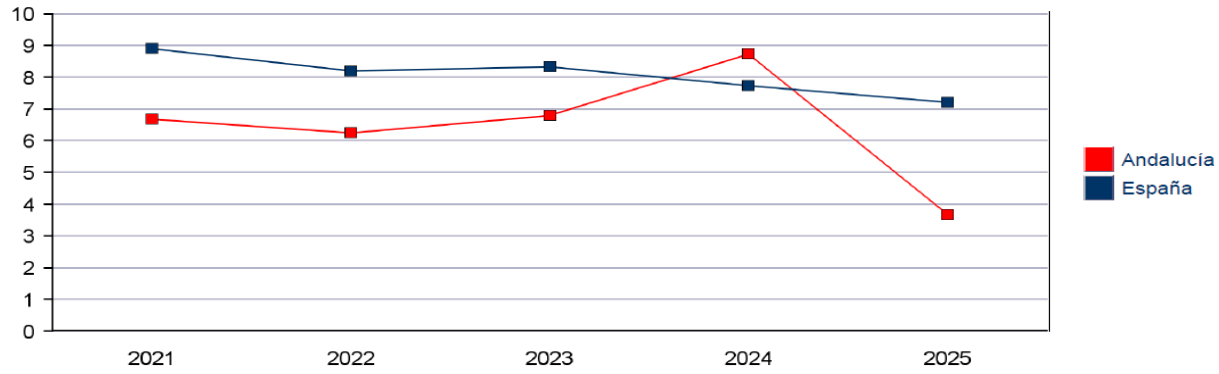


Gráfico 64. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Andalucía. (2021-2025)

Aragón

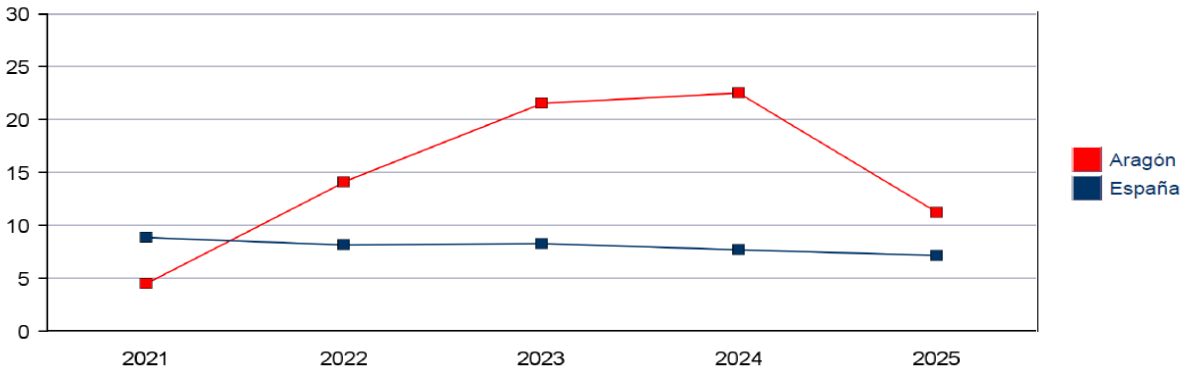


Gráfico 65. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Aragón. (2021-2025)

Asturias

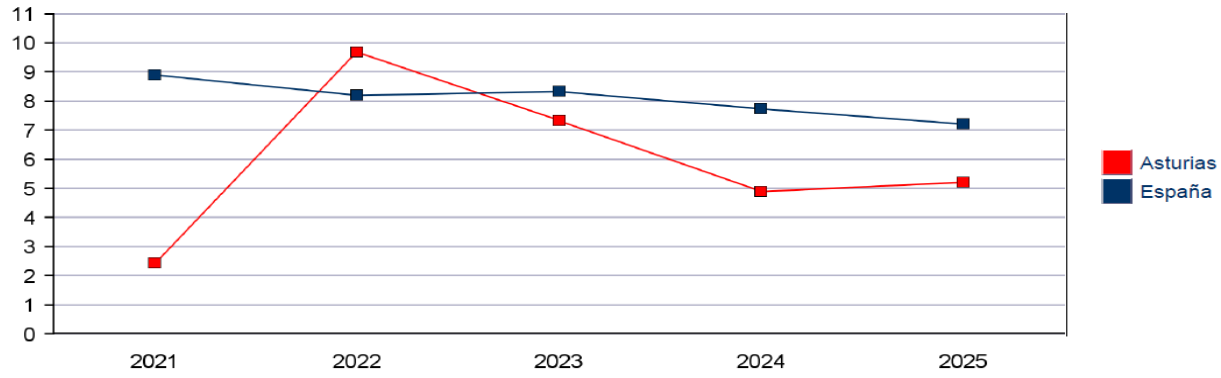


Gráfico 66. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Asturias. (2021-2025)

Baleares

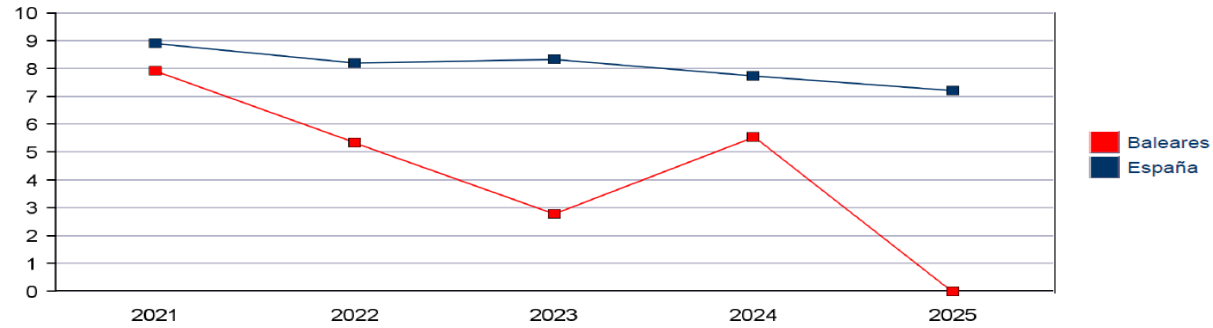


Gráfico 67. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Baleares. (2021-2025)

Canarias

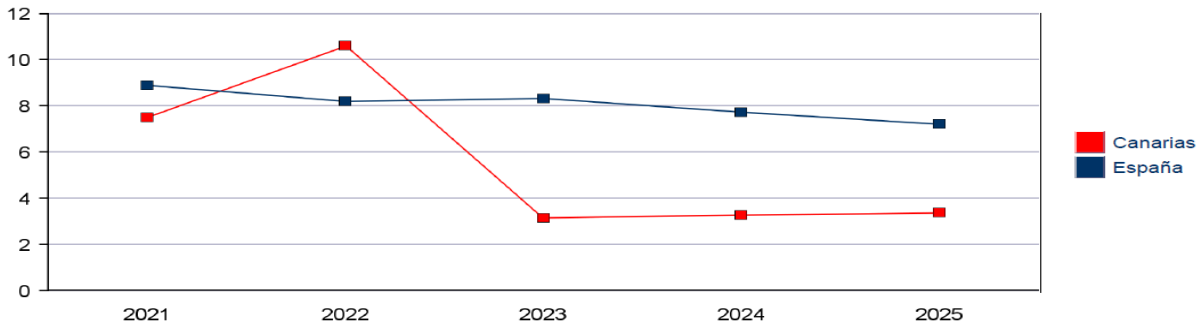


Gráfico 68. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Canarias. (2021-2025)

Cantabria

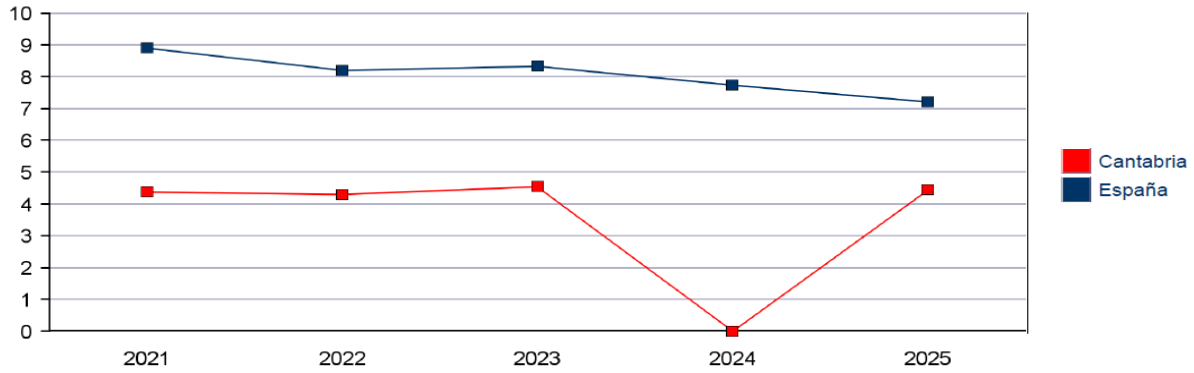


Gráfico 69. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Cantabria. (2021-2025)

Castilla La Mancha

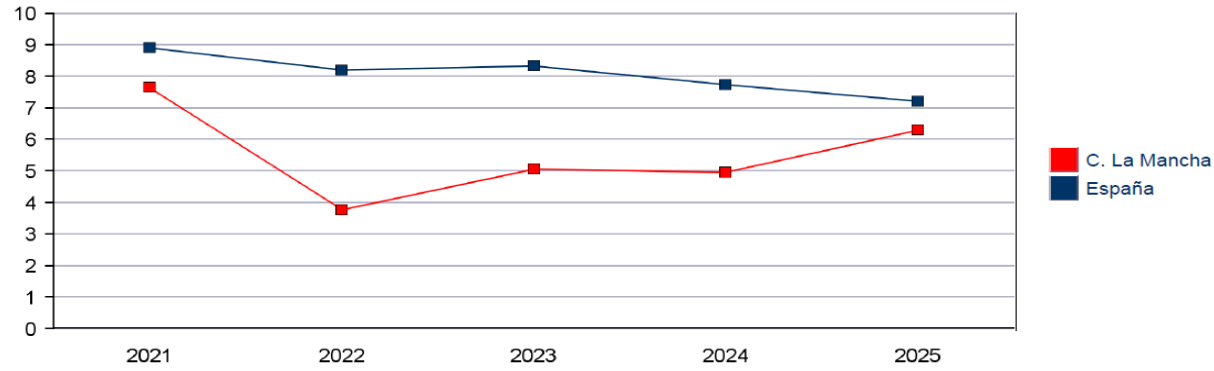


Gráfico 70. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Castilla – La Mancha. (2021-2025)

Castilla Y León

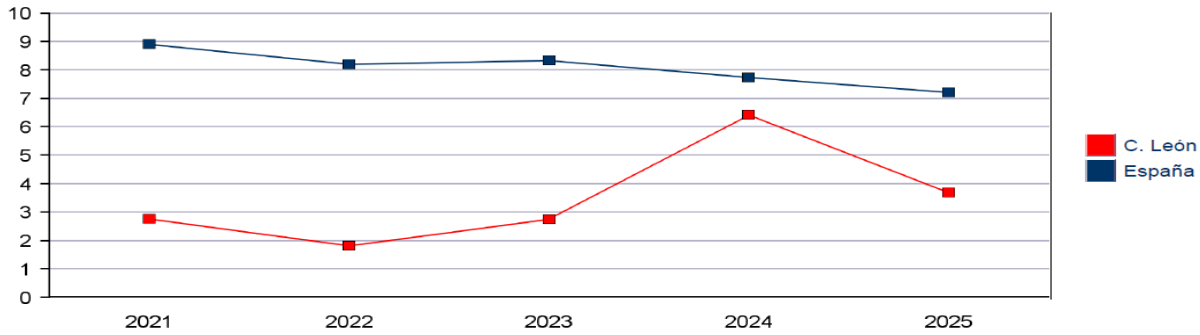


Gráfico 71. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Castilla y León. (2021-2025)

Cataluña

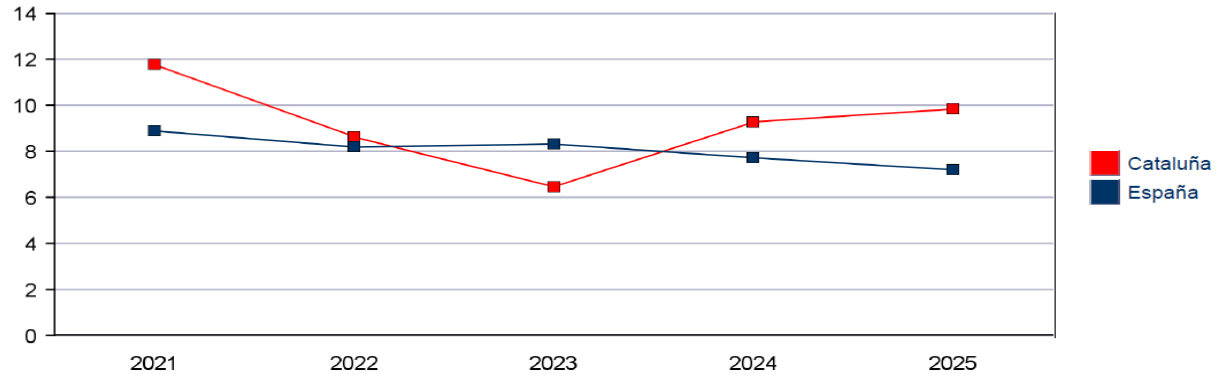


Gráfico 72. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Cataluña. (2021-2025)

Comunidad Valenciana

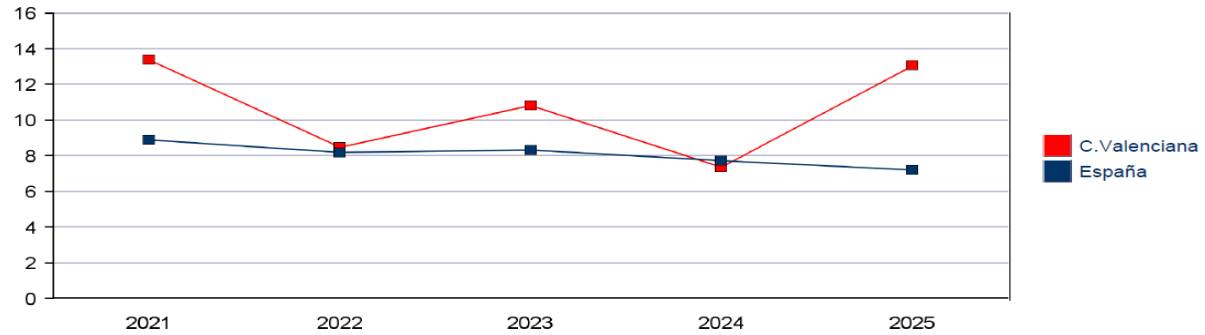


Gráfico 73. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Comunidad Valenciana (2021-2025)

Extremadura

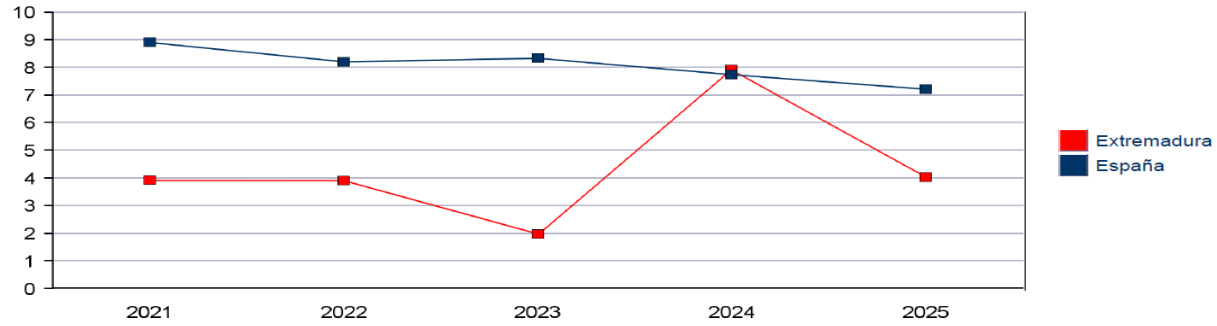


Gráfico 74. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Extremadura. (2021-2025)

Galicia

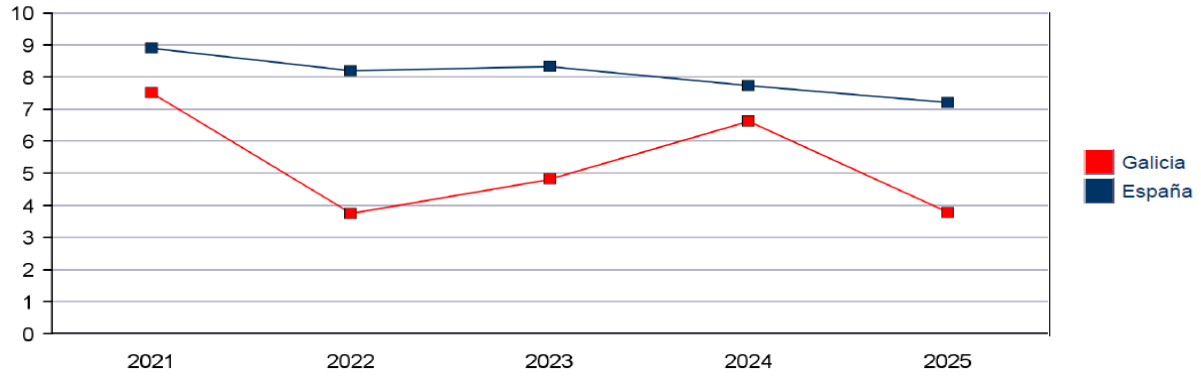


Gráfico 75. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Galicia. (2021-2025)

La Rioja

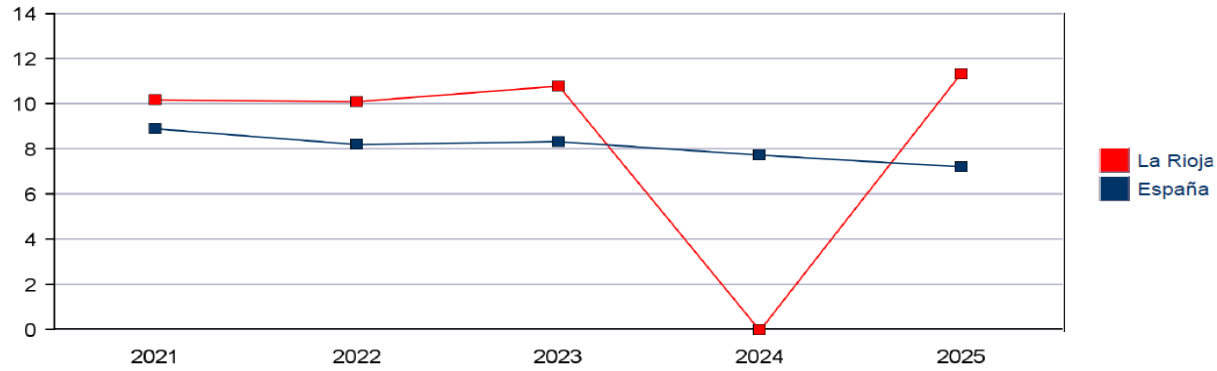


Gráfico 76. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. La Rioja (2021-2025)

Madrid

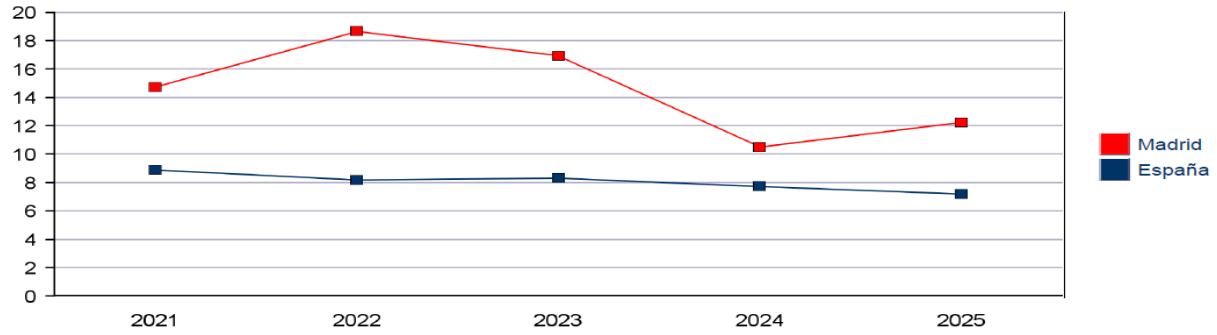


Gráfico 77. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Madrid. (2021-2025)

Murcia

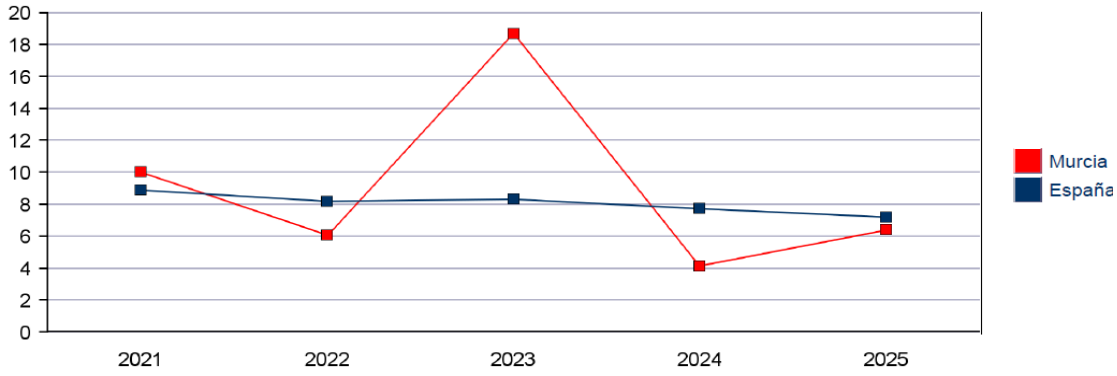


Gráfico 78. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Murcia. (2021-2025)

Navarra

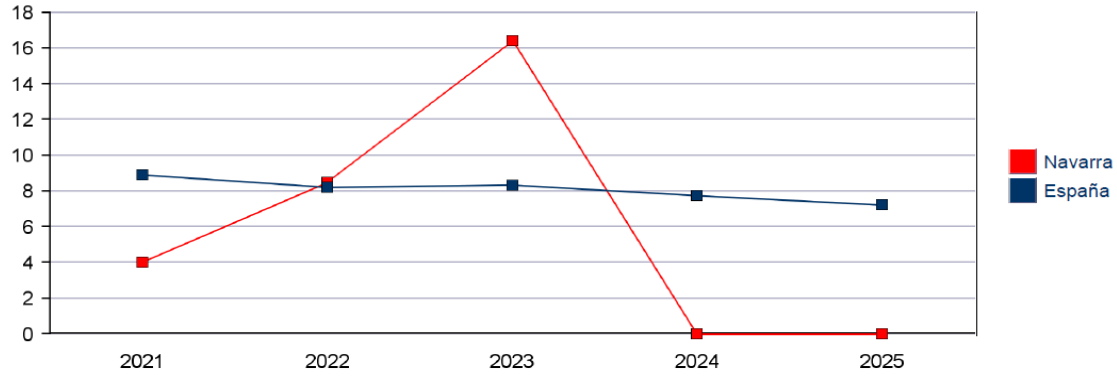


Gráfico 79. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. Navarra. (2021-2025)

País Vasco

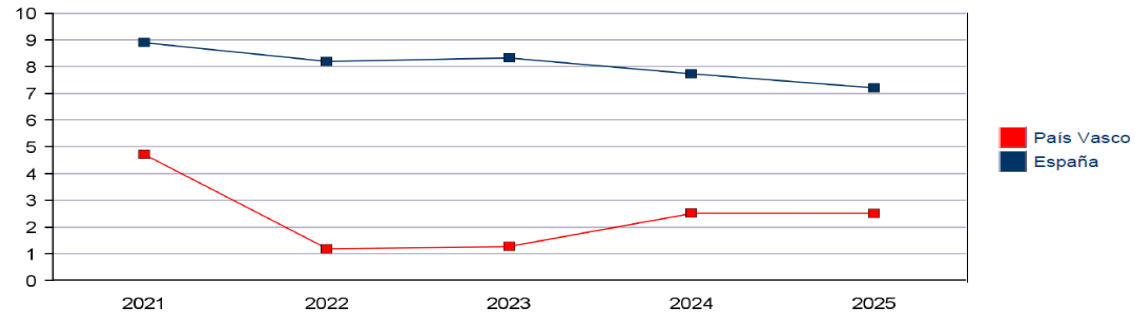


Gráfico 80. Marcadores Obligatorios: VHB. Prevalencia por 100.000 donaciones. País Vasco. (2021-2025)